

ASSOCIATION MARIALE D'ABILI

COMMENT VIVRE-ENSEMBLE AVEC LES SORCIERS,

afin de préserver la paix dans ta famille



(Approche clinique de la Médecine Traditionnelle
des Handicapés Spirituels (MTHS))

**COMMENT VIVRE-ENSEMBLE AVEC LES SORCIERS, AFIN
DE PRESERVER LA PAIX AU SEIN DE TA FAMILLE**

**Approche clinique de la Médecine Traditionnelle
des Handicapés Spirituels (MTHS)**

Tous les droits de traduction, de reproduction et d'adaptation
Réservés pour tous les pays.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photo print,
microfilm, or other means without permission from the publisher.

By Sagesse Africaine, (Cameroun 2026).

📍 **Siège Social : Yaoundé – Cameroun**

☎ **Téléphones : (00237) 641 42 99 18 / (00237) 677 75 73 56**

✉ **E-mail : contact@sagesseafricaine.org**

🌐 **Site web : <https://www.sagesseafricaine.org>**

« Il leur proposa une autre parabole et il dit : Le Royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé de la bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé en herbe et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire : Seigneur, n'as-tu pas semé de la bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y ait de l'ivraie? Il leur répondit : C'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent : Veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson, et, à l'époque de la moisson, je dirai aux moissonneurs : Arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbes pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. »

Matthieu 13.24-30 Marc 2, 17

COLLECTION:

LUMIÈRE ET VÉRITÉ SUR LE MONDE DES TÉNÉBRES

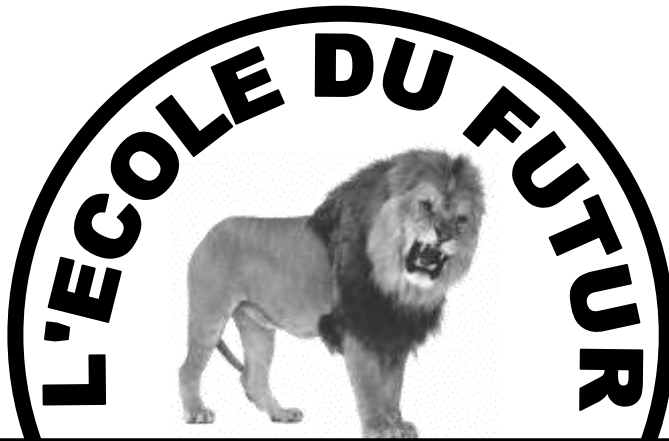
Pour la promotion de la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS)

- 1- Ange ou Démon ? *La nature spirituelle profonde de l'Homme;*
- 2- La Vie nocturne du Sorcier (L'Univers astral de la sorcellerie);
- 3- Les Dix Commandements de Satan;
- 4- Le Satanisme et la dérive du Monde
- 5- La transmission de la Sorcellerie au sein de la famille;
- 6- La Sorcellerie au-dessus de la Foi
- 7-Comment vivre-ensemble avec des sorciers et préserver la paix en famille
- 8- Chrétien africain et la Maladie (Approche de la pastorale des malades))
- 9- Le Chrétien africain face à la Sorcellerie (Approche clinique de la MTHS);
- 10- Le Musulman face à la sorcellerie (Approche de la MTHS)
- 11- Le Bouddhiste face à la sorcellerie et au Satanisme
- 12- Hindouisme et Déviance spirituelle
- 13- La Religion traditionnelle chinoise face à la sorcellerie
- 14- La guerre des spiritualités en Afrique
- 15- Enjeux et défis du contrôle spirituel de l'Homme par les Sociétés Secrètes
- 16- La Puissance Spirituelle du Sexe
- 17- Comment comprendre et interpréter le rêve ?
- 18- Les conséquences du phénomène de Maris et Femmes de nuit
- 19- Les conséquences de la masturbation et de la pornographie dans ta vie
- 20- L'Avenir des traditions ancestrales africaines et le christianisme: Mariage ou divorce
- 21-Comment te soigner des persécutions spirituelles et de la sorcellerie
- 22- Comment obtenir ta Délivrance et ta Victoire sur le Diable, les Démons et les Sorciers
- 23- L'envoûtement par la bible et les objets liturgiques,
- 24-Culture de la paix et lutte contre la déviance spirituelle dans le monde
- 25- L'Hygiène de l'âme.
- 26- La Vie après la mort

« Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. »

Marc 2, 17

*« Je t'envoie pour que tu leur ouvres les yeux, pour que tu les ramène de l'obscurité à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu. S'ils croient en moi, ils recevront le pardon de leurs péchés et une place parmi ceux qui appartiennent à Dieu »
(AC.26, 18)*



**CENTRE D'ÉTUDES DES TRADITIONS, US ET
COUTUMES AFRICAINES ET DE LA RECHERCHE
APPLIQUÉE SUR L'INCULTURATION DU
CHRISTIANISME CHEZ LES PEUPLES
D'AFRIQUE NOIRE**

POUR

- La Culture de la Paix
- L'Éducation citoyenne des jeunes
- Le Dialogue des Cultures et des Religions
- La Valorisation des identités culturelles africaines
- La Vulgarisation de la Recherche sur le Développement Durable
- La lutte contre la déviance spirituelle et les comportements de déviance

LES CLÉFS DU SUCCÈS DE L'ÉCOLE DU FUTUR

L'ÉCOLE DU FUTUR est un Centre Laïc d'études des traditions, us et coutumes africaines et de la recherche appliquée sur l'inculturation du christianisme chez les peuples d'Afrique noire. C'est un Centre de promotion et de vulgarisation de l'éducation citoyenne et de la recherche transdisciplinaire sur : la délivrance spirituelle, "*la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels*" (MTHS) la renaissance spirituelle, la transformation et la rééducation chrétienne des âmes égarées.

NOTRE BUT : Le but poursuivi par nos programmes de formation spirituelle n'est pas d'endoctriner, mais de cultiver plutôt le discernement spirituel, la sanctification des âmes, le développement personnel, la paix de l'Esprit, la Culture de la paix dans les cœurs et les esprits des hommes, la tolérance religieuse, le dialogue des cultures et des religions entre habitants des cinq continent de la Planète Terre.

NOTRE DEVISE : « *Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde* » (Proverbe 28.13).

NOTRE CONVICTION PROFONDE : « *Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples ; vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira.* » (Jean 8 : 31) de la domination du prince de ce monde et de l'emprise des forces des ténèbres.

NOTRE RAISON D'ÊTRE : « *Mon peuple périt faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Je te rejetterai, et tu seras dépouillé de mon sacerdoce; Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, J'oublierai aussi tes enfants* » (OSEE 4.6).

NOTRE METHODE DE TRANSFORMATION :

« *Homme!!! connais-toi d'abord spirituellement toi-même; pour mieux te rapprocher de ton Dieu Créateur* ». Car Dieu étant Esprit, et l'homme étant partiellement esprit, ce n'est que dans sa dimension spirituelle que tout homme peut profondément connaître et se rapprocher de son Dieu Créateur.

NOTRE AMBITION : « **construire un monde de PAIX** », par le moyen des enseignements spécialisés sur *la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels "(MTHS), le Dialogue des cultures et des religions*. Car « **Les guerres et les conflits prenant naissance dans le cœur et l'esprit des hommes, c'est dans le cœur et l'esprit des hommes que doivent être élevées des défenses de la paix** ».

« *Afin que la vérité ne soit plus noyée dans l'ignorance, la confusion et l'esprit de rébellion des hommes. Dans le but que tout homme soit lui-même son propre juge, et qu'il sache désormais ce que le Seigneur lui reproche.* »

(Jean Paul Sylvain SIDA ABENA)

**« Le Seigneur a créé les remèdes de la terre,
et l'homme sage ne les méprise pas. »**
(Ecclésiastique) 38, 4

*« Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance...
renvoyer libres les opprimés. » (Luc 4,18)*

**Traditional Medicine for the Spiritually
Handicapped
(TMSH)**



MTHS

**Médecine Traditionnelle des Handicapés
Spirituels (MTHS)**

**« La médecine révélée pour la guérison intégrale de l'homme :
Corps, Âme et Esprit »**

**« Leurs fruits serviront de nourriture
et leurs feuilles de remède. »**

(Ézéchiél 47, 12)

SOMMAIRE

Préface	P.13
Avant-propos	P.17
Introduction générale	P.24
 PARTIE I – COMPRENDRE AVANT DE JUGER	 P.31
Chapitre 1 – La sorcellerie dans la famille : réalité africaine.....	P.32
Chapitre 2 – Qui est réellement le “sorcier” ?.....	P.39
Chapitre 3 – Handicap spirituel : lecture clinique MTHS.....	P.45
 PARTIE II – LA FAMILLE SOUS TENSION SPIRITUELLE	 P.51
Chapitre 4 – Comment la sorcellerie détruit la paix familiale.....	P.52
Chapitre 5 – Victimes, accusés et boucs émissaires.....	P.59
Chapitre 6 – Quand la religion aggrave le conflit.....	P.68
 PARTIE III – VIVRE-ENSEMBLE SANS SE DÉTRUIRE	 P.76
Chapitre 7 – Peut-on vivre avec un sorcier dans la même famille ?.....	P.77
Chapitre 8 – Protéger la famille sans persécuter.....	P.84
Chapitre 9 – Parler sans accuser : communication thérapeutique.....	P.91
 PARTIE IV – SOIGNER PLUTÔT QUE COMBATTRE	 P.99
Chapitre 10 – Le sorcier comme patient spirituel.....	P.100
Chapitre 11 – Protocoles cliniques de prise en charge.....	P.107
Chapitre 12 – Réintégrer sans naïveté.....	P.115
 PARTIE V – PRÉSERVER LA PAIX SUR LE LONG TERME	 P.122
Chapitre 13 – Éduquer les enfants à l'équilibre spirituel.....	P.123
Chapitre 14 – Famille, tradition et foi : trouver l'équilibre.....	P.130
Chapitre 15 – Vers une culture de paix spirituelle.....	P.138
 Conclusion générale	 P.145

PREFACE

Il existe des livres qui rassurent, d'autres qui instruisent, et quelques-uns, plus rares, qui dérangent suffisamment pour transformer en profondeur notre manière de voir le monde. *Comment vivre-ensemble avec les sorciers, afin de préserver la paix dans ta famille* appartient résolument à cette dernière catégorie. Dès son titre, l'ouvrage provoque, interroge, parfois choque. Et c'est précisément là sa force : il refuse le confort des réponses toutes faites pour ouvrir un espace de réflexion courageux, humain et spirituellement responsable.

Dans de nombreuses sociétés africaines, la sorcellerie n'est pas une idée abstraite ni un simple héritage culturel figé. Elle est une réalité vécue, ressentie, racontée, redoutée. Elle traverse les familles, empoisonne les relations, nourrit les soupçons et, trop souvent, justifie des violences morales, spirituelles et parfois physiques. Des mères sont accusées, des enfants rejetés, des anciens humiliés, des familles éclatées au nom d'une lutte supposée contre le mal. Face à cette tragédie silencieuse, deux attitudes dominant habituellement : le déni rationaliste, qui méprise la souffrance vécue, et la croisade spirituelle, qui transforme la peur en persécution. Ce livre ose une troisième voie.

L'Association Mariale d'Abili ne cherche ni à banaliser la sorcellerie ni à l'ériger en mythe inoffensif. Elle propose plutôt un changement radical de regard : déplacer le centre de gravité du combat, quitter la logique de l'ennemi à abattre pour entrer dans celle de la personne à comprendre, à encadrer, à soigner et,

surtout, à pacifier. Cette posture n'est ni faiblesse ni complaisance. Elle est le fruit d'une longue expérience de terrain, d'écoute des familles brisées et d'observation des dégâts causés par les accusations hâtives et les délivrances violentes.

Au cœur de cette réflexion se trouve une intuition forte : ce que l'on nomme « sorcellerie » est souvent l'expression d'un déséquilibre profond, d'un handicap spirituel, d'une souffrance invisible qui cherche une forme d'expression. Derrière les récits nocturnes, les peurs héréditaires et les conflits mystiques se cachent des blessures psychiques, des traumatismes transgénérationnels, des frustrations sociales, des quêtes de reconnaissance dévoyées. Refuser de voir cette complexité, c'est condamner les familles à une guerre sans fin, où chaque victoire apparente prépare une défaite plus douloureuse encore.

Ce livre pose alors une question fondamentale, à la fois thérapeutique et spirituelle : la paix familiale est-elle négociable ? Peut-on prétendre servir Dieu, la justice ou la vérité en sacrifiant l'unité de la famille, en détruisant des vies par des accusations irréversibles ? L'Association Mariale d'Abili répond avec clarté : la paix n'est pas un luxe, elle est une urgence. Elle est un soin. Elle est parfois la seule porte encore ouverte vers la guérison de l'invisible.

À travers les pages de cet ouvrage, le lecteur est invité à un cheminement intérieur exigeant. Il ne s'agit pas seulement de comprendre la sorcellerie autrement, mais de revisiter sa propre

manière de juger, de craindre, de croire. Le texte déconstruit les confusions dangereuses entre discernement spirituel et suspicion systématique, entre autorité religieuse et abus spirituel, entre foi vivante et violence sacrée. Il met en lumière la responsabilité immense des familles, des leaders spirituels et des communautés dans la fabrication – ou la désescalade – des conflits invisibles.

L'approche proposée, enracinée dans la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS), articule avec finesse anthropologie africaine, éthique chrétienne, clinique de la souffrance spirituelle et pédagogie de la paix. Elle rappelle que soigner ne signifie pas écraser, que délivrer ne veut pas dire humilier, et que protéger une famille exige parfois plus de sagesse que de zèle. Ici, la paix devient un choix thérapeutique, un acte spirituel mûr, une stratégie de survie communautaire.

Ce livre s'adresse à tous ceux qui vivent dans la peur de l'invisible, mais aussi à ceux qui, par ignorance ou excès de certitude, participent à la violence spirituelle ordinaire. Il interpelle les parents, les pasteurs, les prêtres, les thérapeutes, les catéchistes, les chefs traditionnels, mais aussi chaque lecteur confronté un jour à un conflit familial où le soupçon de sorcellerie sert de verdict définitif. Il invite chacun à se demander : quel monde spirituel construisons-nous lorsque nous choisissons l'exclusion plutôt que la guérison ?

Lire Comment vivre-ensemble avec les sorciers, afin de préserver la paix dans ta famille, c'est accepter de marcher sur une

ligne étroite, inconfortable mais profondément humaine. C'est reconnaître que la paix n'est pas l'absence de conflit, mais la capacité de le traverser sans perdre son âme. C'est découvrir que la véritable victoire spirituelle ne réside pas toujours dans la destruction du mal perçu, mais dans la restauration patiente des liens brisés.

Puisse ce livre ouvrir des espaces de dialogue là où régnait la peur, semer de la prudence là où dominait la violence spirituelle, et rappeler à chacun que préserver la paix dans la famille est peut-être, aujourd'hui plus que jamais, l'un des actes les plus élevés de foi, de sagesse et de responsabilité humaine.

L'EDITEUR

AVANT-PROPOS

Pourquoi ce livre était nécessaire aujourd'hui

Il est des livres qui naissent d'une intuition intellectuelle, d'autres d'une urgence historique. Celui-ci relève des deux. Il s'impose comme une réponse à une crise diffuse mais profonde, silencieuse mais ravageuse, qui traverse les familles africaines contemporaines, et plus largement les sociétés où les systèmes de croyances traditionnelles, religieuses et modernes s'entrechoquent sans médiation thérapeutique adéquate.

Depuis plusieurs décennies, l'Afrique et singulièrement ses cellules familiales – est le théâtre d'une tension permanente entre héritages spirituels ancestraux, christianisme institutionnel, nouvelles spiritualités importées, rationalisme biomédical et idéologies de la performance. Dans ce maelström, la figure du **sorcier** est devenue un point de cristallisation des peurs collectives, un réceptacle symbolique de toutes les angoisses non résolues : échecs économiques, maladies chroniques inexplicables, infertilité, décès prématurés, conflits successoraux, ruptures conjugales, troubles psychiques.

Or, paradoxalement, plus la société se modernise, plus la question de la sorcellerie s'intensifie. Non parce que les pratiques augmentent objectivement, mais parce que **les mécanismes traditionnels de régulation, de parole, de soin et de réparation ont été brisés**, sans être remplacés par des dispositifs cliniques culturellement pertinents. La biomédecine traite les corps, la

pastorale classique moralise les âmes, la justice pénale réprime les actes visibles, mais **aucune de ces instances ne prend véritablement en charge le handicap spirituel** comme réalité anthropologique, psychique et relationnelle.

Ce livre était donc nécessaire parce que le silence tue plus sûrement que la parole éclairée. Parce que l'ignorance nourrit la violence. Parce que la peur, lorsqu'elle n'est pas nommée et soignée, se transforme en accusation, en bannissement, en lynchage symbolique ou réel. Parce qu'il devenait urgent de proposer une **lecture clinique, éthique et thérapeutique** de la sorcellerie, non plus comme mythe ou délit, mais comme **symptôme d'une pathologie spirituelle et relationnelle**.

La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS) s'inscrit précisément dans cette nécessité historique : offrir un cadre scientifique, humanisant et pacificateur pour penser l'impensé, soigner l'invisible et restaurer la cohésion familiale et sociale.

Sortir de la peur, du silence et de la violence intra-familiale

La famille est, en Afrique, le premier espace de socialisation, de transmission et de protection. Mais elle est aussi devenue, dans bien des contextes, le premier champ de bataille spirituel. C'est au sein même de la maison que naissent les soupçons, que circulent les accusations, que s'enkystent les rancœurs anciennes. Le sorcier n'est presque jamais un inconnu : il est le parent, l'oncle, la tante, la

grand-mère, parfois même le père ou la mère. Cette proximité rend la peur plus aiguë, la douleur plus intime, la violence plus dévastatrice.

La peur, d'abord, est omniprésente. Peur de tomber malade. Peur de perdre son emploi. Peur de voir ses enfants échouer. Peur de mourir prématurément. Dans l'imaginaire collectif, le sorcier devient la cause ultime, l'agent caché de tous les malheurs. Cette peur, lorsqu'elle n'est pas analysée, s'auto-alimente et produit des comportements irrationnels : fuite, agressivité, hyper-religiosité défensive, consultations multiples et contradictoires, ruptures familiales.

Le silence, ensuite, constitue un second poison. Par honte, par loyauté familiale, par crainte de représailles mystiques ou sociales, on se tait. On ne parle pas des soupçons. On n'exprime pas les traumatismes spirituels vécus dans l'enfance. On garde pour soi les rêves récurrents, les expériences nocturnes, les sensations d'emprise. Ce silence empêche toute élaboration thérapeutique. Il enferme la souffrance dans le non-dit, là où elle devient chronique et transmissible de génération en génération.

Enfin, la violence surgit comme l'ultime issue d'un système saturé. Violence verbale, psychologique, symbolique, parfois physique. Accusations publiques, humiliations, exclusions, héritages confisqués, abandon des personnes âgées, enfermements domestiques, voire meurtres rituels ou lynchages. Dans certains

contextes, la sorcellerie devient un prétexte à la gestion brutale des conflits sociaux et économiques.

La MTHS propose une rupture radicale avec ce cycle mortifère. Elle affirme que **la sorcellerie n'est pas d'abord un crime à punir, mais un trouble à comprendre et à soigner**. Elle replace la peur dans une lecture clinique, le silence dans un espace thérapeutique sécurisé, et la violence dans une dynamique de transformation et de réparation. Sortir de la peur, ce n'est pas nier la réalité du mal, mais l'éclairer. Briser le silence, ce n'est pas exposer pour détruire, mais nommer pour guérir. Désamorcer la violence, ce n'est pas absoudre, mais traiter.

Positionnement éthique : ni complaisance, ni persécution

L'un des défis majeurs de toute approche de la sorcellerie réside dans le positionnement éthique. Trop souvent, les discours oscillent entre deux extrêmes également dangereux : la complaisance naïve ou la persécution aveugle. La première nie la souffrance des victimes et banalise les actes destructeurs. La seconde déshumanise, condamne sans discernement et engendre des injustices irréparables.

La MTHS adopte une troisième voie, exigeante et inconfortable : **la voie de la responsabilité thérapeutique**. Elle reconnaît l'existence de pratiques spirituelles nocives, d'intentions destructrices, de dynamiques de prédation psychique. Mais elle refuse de réduire l'individu à ses actes ou à ses fonctions

symboliques. Le sorcier, dans cette perspective, n'est pas un monstre métaphysique, mais un **sujet en situation de handicap spirituel**, souvent lui-même porteur de traumatismes anciens, de blessures transgénérationnelles, de frustrations sociales non élaborées.

Ce positionnement éthique implique plusieurs principes fondamentaux. D'abord, le refus de l'essentialisation : personne ne naît sorcier par nature. Les comportements sorcellaires s'inscrivent dans des trajectoires de vie marquées par des ruptures, des initiations subies, des pactes contraints, des héritages spirituels non choisis. Ensuite, le principe de non-violence thérapeutique : toute intervention visant à « neutraliser » un sorcier par la force, l'humiliation ou la torture constitue une aggravation du trouble et une violation de la dignité humaine.

Enfin, la MTHS pose le principe de responsabilité graduée. Reconnaître le handicap spirituel ne signifie pas nier la nécessité de réparation. Il s'agit d'articuler soin, protection des victimes, restauration des liens et, lorsque nécessaire, mise à distance temporaire. La clinique de la MTHS ne cherche ni à excuser ni à condamner moralement, mais à **transformer des dynamiques destructrices en processus de guérison individuelle et collective**.

Ce positionnement éthique est sans doute l'aspect le plus révolutionnaire de cette approche. Il exige du praticien, du pasteur, du chef de famille, du thérapeute, une maturité spirituelle et

intellectuelle rare : celle de tenir ensemble vérité et compassion, lucidité et miséricorde, justice et soin.

La MTHS comme voie de lucidité, de soin et de paix sociale

La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels s'inscrit à la croisée de plusieurs disciplines : anthropologie médicale, psychologie clinique, théologie contextualisée, traditions thérapeutiques africaines, éthique du soin et sciences sociales. Elle ne se contente pas d'interpréter les phénomènes spirituels ; elle propose des **protocoles cliniques d'évaluation, de prise en charge et de suivi** des situations de sorcellerie intra-familiale.

La lucidité constitue sa première contribution. En nommant le handicap spirituel, la MTHS rompt avec les catégories floues et émotionnelles. Elle distingue les troubles imaginaires des expériences spirituelles authentiques, les projections psychiques des actes intentionnels, les héritages symboliques des pratiques effectives. Cette clarification apaise les familles, réduit les accusations infondées et redonne au discernement sa place centrale.

Le soin est sa seconde vocation. La MTHS développe des itinéraires thérapeutiques intégrés, associant écoute clinique, rituels de désengagement spirituel, accompagnement psychologique, médiation familiale et, lorsque nécessaire, collaboration avec la biomédecine. Elle considère le sorcier non comme un ennemi à

abattre, mais comme un patient complexe, dont la guérison contribue directement à la sécurité et à la paix du groupe.

Enfin, la paix sociale constitue son horizon ultime. Une famille pacifiée est une cellule sociale stabilisée. Une communauté capable de traiter la sorcellerie sans violence est une société résiliente. En ce sens, la MTHS dépasse le cadre thérapeutique pour devenir un **outil de prévention des conflits, de cohésion sociale et de reconstruction du vivre-ensemble**.

Ce livre s'adresse donc à tous ceux qui refusent la fatalité de la haine familiale, à ceux qui cherchent des réponses sérieuses sans renier leur culture, à ceux qui aspirent à une spiritualité mature, capable de guérir sans détruire. Il invite à un changement de regard, à une conversion de l'intelligence et du cœur. Non pour nier l'existence du mal, mais pour apprendre enfin à le soigner sans se perdre soi-même.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

La question taboue de la sorcellerie familiale

En Afrique contemporaine, la sorcellerie n'est pas seulement un phénomène spirituel ; elle est d'abord un marqueur social et psychologique. Mais cette réalité, souvent dissimulée derrière le voile du silence, de la peur ou de la superstition, demeure un sujet **tabou** dans la plupart des familles. Les accusations de sorcellerie, qui jadis se régulaient dans des rituels communautaires ou des instances traditionnelles, se déplacent aujourd'hui dans l'espace intime de la cellule familiale. La grand-mère, l'oncle, le frère ou la sœur deviennent des figures à la fois craintes et incomprises, leurs actes interprétés à travers un prisme de suspicion et de malheur.

Le tabou s'exprime de plusieurs manières. D'abord par le **silence imposé** : on ne parle pas de l'"affaire" pour éviter le scandale, la honte, ou des représailles spirituelles. Ensuite, par la **censure sociale** : reconnaître la présence d'un sorcier dans sa famille expose à l'incrédulité ou au ridicule, voire à l'exclusion. Enfin, par la **projection psychologique** : les membres de la famille minimisent ou occultent leur souffrance pour maintenir une façade de normalité. Ce silence a pour effet de renforcer la peur et de rendre les conflits internes invisibles mais profondément destructeurs.

La sorcellerie familiale, loin d'être une légende folklorique, constitue un **enjeu réel de santé mentale et sociale**. Des études anthropologiques récentes montrent que l'exposition prolongée à la

suspicion et à la crainte de sorcellerie déclenche des troubles anxieux, des dépressions, des phobies intrafamiliales, et même des pathologies psychosomatiques sévères. La peur du sorcier devient une **pathologie de l'environnement social**, un stress chronique qui érode les liens de confiance et de solidarité.

Dans ce contexte, le **refus de nommer la réalité** ne protège pas la famille ; il l'expose à une forme de guerre silencieuse, où chaque malaise, chaque accident, chaque perte est interprété comme une attaque occulte. Le tabou, paradoxalement, nourrit la destruction qu'il prétend prévenir.

Vivre-ensemble ou guerre permanente : un choix de société

L'enjeu dépasse la famille : il s'agit d'un **choix social et civilisationnel**. Une société où la sorcellerie est taboue, où les conflits invisibles ne sont pas médiés, où la peur dicte les comportements, court le risque d'une **dynamique permanente de guerre intra-familiale et communautaire**. Les enfants grandissent dans un climat de suspicion ; les couples se délient autour de suspicions mutuelles ; les relations intergénérationnelles se tendent jusqu'à devenir conflictuelles.

Vivre-ensemble avec la conscience de la sorcellerie n'implique pas l'acceptation naïve ou la complaisance ; c'est un **engagement éthique et pratique**, qui suppose d'adopter des stratégies conscientes de prévention, de médiation et de réparation. La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS) offre

justement ces outils. Elle permet de transformer la peur en discernement, la suspicion en dialogue, et la tension en régulation.

Le choix est donc clair : continuer à laisser la sorcellerie dicter le silence et la violence ; ou apprendre à **cohabiter de manière consciente**, avec des protocoles de soin et de prévention adaptés, pour préserver la paix familiale. Cette cohabitation n'est ni un luxe ni une concession : elle est une **nécessité thérapeutique et sociale**.

Clarification du vocabulaire : sorcier, victime, handicap spirituel

La précision terminologique est cruciale. Dans un contexte où les mots sont porteurs de jugement, de peur et de stigmatisation, définir les concepts permet d'établir un terrain commun pour la réflexion scientifique et pratique.

1. Sorcier : dans la MTHS, le sorcier n'est pas réduit à une figure maléfique ou démoniaque ; il est défini comme un **individu porteur d'un handicap spirituel** qui se manifeste par des comportements, des intentions ou des effets perçus comme destructeurs. Ce handicap peut résulter d'expériences traumatiques, d'influences transgénérationnelles, de pactes contraints ou d'une incapacité à réguler ses pouvoirs spirituels. La MTHS distingue ainsi **le sorcier intentionnel de l'individu en souffrance**, et propose des interventions différenciées.

2. Victime : ce terme désigne tout membre de la famille ou de la communauté affecté par les actes du sorcier, que ce soit par

maladie, accident, troubles psychologiques ou perte sociale. La victime n'est pas simplement passivement affectée : elle est également porteuse de **résilience et de potentialités thérapeutiques**. Le rôle du praticien MTHS est d'évaluer le degré de vulnérabilité et de renforcer les stratégies de protection, de réparation et de rétablissement.

3. Handicap spirituel : concept central de la MTHS, il décrit **un dysfonctionnement ou une incapacité dans le registre spirituel**, entraînant des effets visibles ou invisibles sur soi-même et sur l'environnement familial. Le handicap spirituel ne présume pas de la moralité de l'individu, mais de la nécessité d'un **traitement clinique et rituel**, analogue à une pathologie biomédicale ou psychologique.

Cette clarification n'est pas académique : elle constitue la première étape pour **éviter les confusions qui nourrissent le conflit familial**. En nommant correctement les acteurs et les phénomènes, la MTHS crée un cadre de dialogue, de soin et de prévention.

Objectifs du livre et méthodologie MTHS

L'objectif principal de cet ouvrage est triple :

1. **Inform** : présenter une vision scientifique et pratique de la sorcellerie familiale, en la replaçant dans le cadre de la MTHS.
2. **Protéger et guérir** : fournir des outils cliniques, rituels et psychothérapeutiques pour gérer les relations avec les

sorciers, réduire la violence intra-familiale et restaurer l'harmonie.

3. **Prévenir et pacifier** : proposer des stratégies de médiation, d'éducation et de transformation sociale pour éviter que la peur et le silence n'installent la guerre permanente.

Pour atteindre ces objectifs, la méthodologie MTHS combine plusieurs approches :

a) Approche clinique intégrative :

La MTHS s'inspire des principes de la médecine psychosomatique et des sciences sociales : chaque situation est analysée selon les **dimensions individuelles, familiales, communautaires et spirituelles**. Les symptômes observés (maladies chroniques inexplicables, troubles psychiques, accidents répétés) sont considérés comme des manifestations du handicap spirituel, nécessitant un **diagnostic différentiel complet**.

b) Méthodologie ethnographique et participative :

La famille est étudiée comme un **système vivant**, où chaque interaction peut amplifier ou réduire les effets du handicap spirituel. L'observation, l'entretien et la participation active aux rituels et pratiques culturelles permettent d'identifier les mécanismes de transmission, les alliances invisibles et les points de tension.

c) Protocole thérapeutique :

La MTHS définit une **suite d'interventions graduées**, combinant :

- Médiation familiale et psychothérapie adaptée aux croyances locales.
- Rituels de désengagement spirituel ou de purification, effectués sous supervision clinique.
- Conseils de prévention et renforcement de la résilience pour les victimes et les témoins.
- Suivi longitudinal pour évaluer l'évolution des dynamiques familiales et des symptômes associés.

d) Cadre éthique strict :

Toutes les interventions respectent les principes de non-violence, de consentement éclairé, de confidentialité et de responsabilité graduée. La MTHS refuse toute manipulation coercitive, toute stigmatisation ou punition extrême. L'objectif est **le soin et la pacification**, non la rétribution ou la vengeance.

e) Approche narrative et littéraire :

Pour que le savoir devienne opératoire, ce livre adopte un style **immersif et narratif**, intégrant des exemples cliniques, des récits familiaux anonymisés, des dialogues types et des métaphores culturelles. Cette approche facilite la **compréhension, la mémorisation et l'application pratique**, tout en respectant la richesse et la complexité des systèmes de croyances africains.

En définitive, La sorcellerie familiale n'est ni un mythe, ni une fatalité : elle est un phénomène complexe, **psychosocial, spirituel et culturel**, dont la gestion exige lucidité, discernement et méthode. Vivre-ensemble avec les sorciers est possible ; cela requiert une

approche clinique, éthique et thérapeutique, telle que la propose la MTHS.

Cet ouvrage s'adresse à ceux qui souhaitent **préserver la paix dans leur famille**, sans renoncer à leur foi, à leur culture ou à leur rationalité. Il vise à transformer la peur en savoir, le silence en dialogue, et la tension en harmonie.

Dans les chapitres suivants, nous détaillerons les **outils, protocoles et stratégies concrètes** pour identifier les handicaps spirituels, accompagner les victimes, réguler les comportements sorcellaires et instaurer une culture familiale de paix et de coexistence consciente.

PARTIE- I :
COMPRENDRE AVANT DE JUGER
Déconstruire les peurs et les mythes

CHAPITRE-1 :

LA SORCELLERIE DANS LA FAMILLE : REALITE AFRICAINE

Sorcellerie et intimité familiale

La sorcellerie n'est pas un phénomène extérieur. Elle ne se manifeste pas seulement dans des forêts reculées, des rituels nocturnes ou des récits mythiques : elle s'invite dans les maisons, dans les chambres, dans les repas familiaux et les conversations quotidiennes. L'intimité familiale, espace par excellence de sécurité et d'affection, devient paradoxalement le premier lieu où la peur et la méfiance s'installent.

Dans les familles africaines, la sorcellerie prend une dimension **symbolique et pratique**. Les enfants interprètent des accidents domestiques comme des attaques occultes ; les adolescents attribuent leurs échecs scolaires aux influences malignes des oncles ou des cousins ; les adultes justifient les revers professionnels par la jalousie invisible d'un frère ou d'une sœur. Ces perceptions ne sont pas simplement le fruit d'une imagination débridée : elles sont enracinées dans des systèmes de croyances qui combinent **cosmologie traditionnelle, religion, psychologie sociale et transmission intergénérationnelle des peurs**.

L'intimité familiale offre un terrain fertile à la sorcellerie pour plusieurs raisons. D'abord, la proximité constante permet une observation quasi-permanente, facilitant l'**interprétation de chaque événement comme signe ou menace**. Ensuite, la dépendance affective crée une vulnérabilité psychologique : un enfant, un

conjoint ou un parent ne peut fuir l'espace familial et se retrouve confronté à la puissance symbolique du sorcier perçu. Enfin, la famille agit comme **médiateur culturel** : ce sont souvent les anciens, les grands-parents ou les chefs de maison qui légitiment la lecture des événements, donnant ainsi **une autorité morale à l'accusation**.

Le premier enseignement de la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS) est ici capital : **il n'existe pas de sorcellerie sans perception, pas de sorcier sans témoin, pas de malheur sans contexte relationnel**. Comprendre cette intimité, c'est comprendre que chaque accusation, chaque suspicion, chaque ressentiment, est un **indice clinique et social**, révélateur d'une dynamique familiale à la fois symbolique et réelle.

Pourquoi la famille est le premier champ de conflits spirituels

Les conflits spirituels dans la famille ne surgissent pas par hasard : ils sont l'expression d'une **interaction complexe entre histoire personnelle, mémoire collective et enjeux sociaux**. Plusieurs facteurs expliquent pourquoi le foyer devient le premier champ de tension :

1. **Transmission intergénérationnelle** : Les familles africaines conservent des récits anciens de sorcellerie, de pactes et de malédictions. Les enfants grandissent dans un univers où le surnaturel explique les réussites et les échecs, où l'esprit des ancêtres est omniprésent et où le mal peut être ciblé sur un

membre spécifique. La mémoire familiale agit comme un **filtre perceptif**, amplifiant certains incidents et occultant d'autres.

2. **Proximité affective et dépendance économique** : La famille est le lieu de la dépendance : enfants, conjoints, parents et grands-parents sont interconnectés. Une dispute sur l'héritage, une rivalité entre frères, ou un conflit conjugal devient rapidement **un prétexte à l'accusation de sorcellerie**. La dépendance affective et économique accentue la peur et le ressentiment.
3. **Multiplicité des rôles et des attentes** : Dans le cadre familial, chaque membre assume plusieurs fonctions : éducative, économique, spirituelle, affective. Lorsque l'un de ces rôles est perçu comme défaillant ou menaçant, les soupçons de sorcellerie surgissent. La MTHS observe que la **cible du sorcier est souvent celui qui menace l'équilibre ou la hiérarchie familiale**, volontairement ou non.
4. **Absence de médiation formelle** : Contrairement aux conflits communautaires, où les chefs traditionnels, les devins ou les prêtres peuvent intervenir, les conflits intra-familiaux se déroulent souvent dans le **secret et le non-dit**, sans médiation institutionnelle. Cette absence de régulation crée un **climat de suspicion permanente**, propice à la répétition des malheurs perçus.

Cas typiques observés en milieu africain

Pour illustrer ces dynamiques, il est essentiel d'exposer quelques **cas types**, observés sur le terrain par des praticiens de la MTHS. Les noms et lieux sont anonymisés pour respecter l'éthique clinique, mais les situations sont représentatives des phénomènes réels.

Cas 1 : La grand-mère et la maladie de l'enfant

Dans un village du Centre Cameroun, une mère amène son fils de sept ans à la consultation pour des crises récurrentes de convulsions inexplicées. La famille soupçonne la grand-mère paternelle, récemment revenue d'un voyage initiatique, d'avoir jeté un sort. L'évaluation MTHS révèle plusieurs facteurs : l'enfant souffre de **troubles neurologiques mineurs**, amplifiés par l'angoisse maternelle et l'interprétation culturelle de ses symptômes. Le protocole MTHS a inclus : éducation sur le mécanisme des crises, rituel de purification symbolique pour la grand-mère, suivi psychologique de l'enfant et médiation familiale. Résultat : réduction des crises, apaisement des tensions intergénérationnelles et restauration d'un climat de confiance.

Cas 2 : La rivalité entre sœurs

Une famille urbaine fait face à des conflits permanents entre deux sœurs adultes, accusant chacune l'autre de sorcellerie lors des échecs professionnels. Les enquêtes MTHS montrent que la rivalité est amplifiée par des comparaisons constantes de réussite académique et économique, combinées à des récits familiaux de

favoritisme. L'intervention a consisté en : séances de médiation structurée, identification des perceptions déformées, rituels symboliques pour neutraliser les rancunes héritées, et recommandations pour des interactions respectueuses. L'expérience montre que **la sorcellerie agit souvent comme métaphore des tensions émotionnelles et sociales**, et que la médiation thérapeutique peut désamorcer des années de conflits.

Cas 3 : Le conjugal et les malheurs financiers

Un couple marié depuis dix ans se présente pour des « attaques spirituelles » : pertes d'emploi, accidents domestiques, tensions avec les enfants. L'analyse MTHS révèle que la perception de sorcellerie découle d'un **stress chronique, de malentendus conjugaux et de traumatismes non résolus** chez le mari. La stratégie a combiné : accompagnement psychologique, rituels d'harmonisation symbolique, révision des modes de communication et engagement dans des projets communs pour restaurer la confiance. Après plusieurs mois, le couple signale une réduction significative des tensions et une meilleure cohésion familiale.

Ces cas démontrent un principe fondamental de la MTHS : **la sorcellerie perçue est souvent la manifestation d'un déséquilibre relationnel, émotionnel et symbolique**, plus que d'une activité occulte malveillante. Comprendre le phénomène dans sa complexité est la première étape vers la pacification.

Entre croyance culturelle et expérience vécue

La sorcellerie familiale s'inscrit à l'intersection de **la croyance culturelle et de l'expérience vécue**. La croyance fournit le cadre explicatif : elle organise la perception, attribue des causes, légitime des comportements et prescrit des interventions. L'expérience vécue, elle, consiste en les **manifestations tangibles ou perçues de la sorcellerie** : maladies, accidents, échecs, conflits, sentiments de peur ou de malaise.

Dans le milieu africain, ces deux dimensions sont indissociables : **la croyance amplifie la perception, et la perception renforce la croyance**. La MTHS insiste sur cette interaction : la pacification ne peut se contenter de rationaliser le phénomène ni de le réduire à un mythe ; elle doit travailler sur les perceptions, les émotions et les croyances de manière intégrée, pour produire un effet thérapeutique et social réel.

La démarche MTHS combine plusieurs instruments :

- **Observation clinique** : analyse des symptômes physiques, psychologiques et relationnels.
- **Entretien ethnographique** : compréhension des récits familiaux et des mythes transmis.
- **Évaluation spirituelle** : identification des perceptions de malédiction, de jalousie et d'attaques occultes.
- **Intervention systémique** : médiation familiale, rituels symboliques, accompagnement psychologique et prévention.

Cette approche permet de **déconstruire les peurs irrationnelles**, de clarifier les malentendus, et de transformer la famille en un lieu de sécurité, même face aux tensions spirituelles. Le sorcier n'est plus seulement une menace : il devient un **indicateur clinique et social** permettant de diagnostiquer, soigner et pacifier.

Transition vers la suite du livre

Après avoir compris pourquoi la famille constitue le premier terrain de sorcellerie et comment les perceptions, croyances et expériences interagissent, le lecteur est préparé à la **PARTIE II**, qui abordera les **stratégies concrètes pour vivre-ensemble**. La connaissance préalable des dynamiques familiales, des cas types et des mécanismes de perception est indispensable : **on ne peut agir efficacement que si l'on comprend avant de juger**.

Ce chapitre inaugure ainsi un fil rouge : **la sorcellerie n'est pas une fatalité, la peur n'est pas une norme, et le silence n'est pas la solution**. Chaque page suivante développera des **protocoles cliniques, méthodes de médiation et outils d'harmonisation familiale**, dans le respect de l'éthique et de la tradition, mais avec la lucidité et la rigueur scientifique de la MTHS.

CHAPITRE- 2 :

QUI EST REELLEMENT LE “SORCIER” ?

Sorcier actif, sorcier passif, sorcier hérité

Lorsque l'on parle de sorcellerie dans la famille, la première confusion surgit au niveau de la définition même du sorcier. Dans l'imaginaire collectif, il est souvent perçu comme **l'agent délibéré du mal**, celui qui, par volonté et pouvoir occultes, provoque des accidents, des maladies ou des malheurs. La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS) nuance cette perception : le sorcier n'est pas un être monolithique, mais un **profil complexe, gradué et dynamique**, que l'on peut classer selon trois dimensions : actif, passif ou hérité.

Le sorcier actif est celui dont les actes sont visibles et intentionnels. Ses manipulations spirituelles ou magiques ont un objectif conscient : nuire, contrôler ou exploiter. Il correspond à la figure classique décrite dans la croyance populaire, mais la MTHS insiste sur la distinction : ces actes, même intentionnels, **sont toujours le symptôme d'un handicap spirituel non soigné**, qui se traduit par un dysfonctionnement moral, relationnel ou psychique.

Le sorcier passif, au contraire, n'agit pas avec une volonté consciente de nuire. Ses actions ou omissions génèrent des effets perçus comme malveillants, mais il n'existe pas d'intention maléfique. Il peut s'agir d'une **projection de ses propres**

traumatismes ou de ses incapacités spirituelles, entraînant des conséquences involontaires sur les autres. Ici, l'enjeu n'est pas la punition mais le soin : comprendre l'origine du dysfonctionnement et intervenir pour restaurer la conscience et la responsabilité spirituelle.

Le sorcier hérité désigne une situation où la personne est investie d'un héritage spirituel, souvent transgénérationnel, qui la lie à des forces occultes ou des pactes anciens. Le sorcier hérité peut ne pas avoir choisi sa condition ; il subit les effets d'un **patrimoine spirituel dont il doit apprendre à se libérer ou à réguler les manifestations**. La MTHS considère ce profil comme l'un des plus délicats : il demande un accompagnement thérapeutique long et structuré, combinant rituels, guidance psychospirituelle et médiation familiale.

Sorcier conscient et sorcier inconscient

Au-delà de l'activité, la MTHS distingue la **conscience du sorcier**. Certains sont pleinement conscients de leurs actes et de leurs effets ; d'autres opèrent de manière inconsciente, en raison de déficits de perception, de traumatismes non traités ou de conditionnements culturels et symboliques.

Le sorcier conscient reconnaît ses actions, mais il peut être prisonnier d'un **handicap spirituel** : incapacité à réguler ses pouvoirs, à comprendre les conséquences de ses actes ou à canaliser son énergie spirituelle. Il n'est pas nécessairement

« maléfique par nature », mais il est **malade spirituellement**, et ses interventions non régulées peuvent causer des dégâts.

Le sorcier inconscient agit sous l'effet de forces qu'il ne maîtrise pas : impulsions héritées, possessions transgénérationnelles, traumatismes enfouis. Dans ce cas, la responsabilité morale est atténuée : l'objectif thérapeutique devient la **conscience et la régulation**, plutôt que la répression. La MTHS développe ici des protocoles spécifiques : éveil progressif, accompagnement symbolique et éducatif, et apprentissage de l'autoprotection spirituelle.

Le sorcier comme malade spirituel selon la MTHS

L'une des contributions majeures de la MTHS est de **reconstruire le sorcier comme un malade spirituel**, plutôt que comme un agent de mal absolu. Cette perspective transforme radicalement la lecture des conflits familiaux :

1. Le sorcier est **un individu en souffrance**, dont les manifestations destructrices sont le symptôme d'un déséquilibre interne.
2. Sa dangerosité n'est pas la preuve de sa nature malveillante, mais la conséquence d'un **handicap spirituel non diagnostiqué ni soigné**.
3. Comme dans toute pathologie, la reconnaissance précoce, l'évaluation systémique et l'accompagnement thérapeutique permettent de **prévenir l'aggravation et de restaurer l'équilibre familial**.

La MTHS applique ici des méthodes intégratives : observation clinique, dialogue familial, rituels de régulation, soutien psychologique et éducation spirituelle. Le sorcier cesse d'être perçu uniquement comme un ennemi et devient **le centre d'un processus de soin, à la fois individuel et collectif**.

Différence entre malveillance et handicap spirituel

Il est crucial de distinguer la **malveillance consciente** du **handicap spirituel**. La malveillance implique une intention délibérée de nuire, souvent alignée sur des choix moraux et stratégiques. Le handicap spirituel, lui, désigne une **incapacité à réguler ses facultés spirituelles, à comprendre les conséquences ou à contrôler ses interactions énergétiques avec l'environnement familial**.

Cette distinction a des implications thérapeutiques et éthiques :

- Dans le cas de **malveillance**, l'intervention peut inclure des mesures de protection, de médiation et, dans certains contextes, des sanctions symboliques ou communautaires.
- Dans le cas de **handicap spirituel**, le but est **la guérison, l'éducation et la pacification**, sans stigmatisation ni persécution.

La confusion entre ces deux réalités est à l'origine de nombreux conflits familiaux et communautaires : des innocents sont accusés à tort, et des malades spirituels subissent des violences injustes. La MTHS met en garde : **juger avant de comprendre entraîne plus de dégâts que la sorcellerie elle-même**.

Illustration par des cas cliniques

Cas 1 : La cousine héritière

Dans un village du Sud-Cameroun, une jeune femme est perçue comme responsable de la stérilité et des accidents domestiques dans sa famille élargie. L'analyse MTHS révèle un **sorcier hérité** : elle a reçu un pacte ancestral non régulé, transmis par sa grand-mère. Ses manifestations destructrices sont involontaires. Le protocole inclut : rituels de purification, médiation familiale et suivi psychospirituel. Six mois plus tard, les tensions sont apaisées et la famille rétablit un fonctionnement normal.

Cas 2 : Le frère passif

Un homme adulte est accusé par ses neveux de provoquer des maladies à répétition. Les investigations montrent qu'il est **sorcier passif** : il n'a jamais eu conscience de son impact spirituel, mais son anxiété chronique et son stress prolongé projettent des énergies perçues comme malveillantes. L'intervention MTHS combine relaxation, rééducation émotionnelle, rituels symboliques et éducation familiale. La perception de danger disparaît progressivement.

Cas 3 : Le sorcier actif conscient

Un jeune homme urbain manipule des forces spirituelles pour obtenir un avantage professionnel. Il est conscient de ses actes et cherche le pouvoir. La MTHS adopte ici une approche éthique stricte : protection des victimes, éducation sur les conséquences et suivi thérapeutique ciblé. L'objectif n'est pas la répression, mais la **transformation du comportement et la prévention des dommages**.

Conclusion

Ce chapitre a pour objectif de **déconstruire l'image du sorcier** : il n'est ni un être intrinsèquement malfaisant, ni une abstraction mythique. Il existe sous plusieurs formes : actif, passif, hérité ; conscient ou inconscient ; malveillant ou malade spirituel. La MTHS invite à **observer, analyser et soigner**, plutôt que juger et punir.

Comprendre le sorcier est essentiel pour pouvoir **vivre-ensemble en sécurité et en harmonie**, ce qui constitue le cœur de la PARTIE II. Les chapitres suivants détailleront **les stratégies de cohabitation, les protocoles de protection et les méthodes de pacification familiale**, tout en s'appuyant sur l'approche clinique, éthique et narrative de la MTHS.

CHAPITRE- 3 :

HANDICAP SPIRITUEL :

LECTURE CLINIQUE DE LA MTHS

Définition du handicap spirituel

Dans le cadre de la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS), le concept de **handicap spirituel** représente une avancée méthodologique et éthique majeure. Loin des accusations stéréotypées ou des jugements moraux simplistes, il s'agit d'un **dysfonctionnement dans la régulation et la perception des forces spirituelles**. Autrement dit, le handicap spirituel décrit une incapacité de l'individu à gérer ses propres facultés spirituelles, à intégrer correctement les influences invisibles de son environnement ou à comprendre les conséquences de ses actes dans le réseau familial et communautaire.

Le handicap spirituel n'implique pas automatiquement une intention malveillante. Il peut se manifester par des comportements **perturbateurs, incompris ou inquiétants**, qui affectent les autres, mais sans volonté consciente de nuire. L'approche clinique MTHS permet de diagnostiquer ces dysfonctionnements, d'évaluer leur intensité et d'élaborer des **protocoles de soin adaptés**.

Cette définition rompt avec deux visions souvent confondues : celle qui identifie le sorcier uniquement à la malveillance, et celle qui réduit la sorcellerie à un mythe folklorique. Le handicap spirituel est un **phénomène réel, observable, mesurable et thérapeutique**, et sa reconnaissance est la condition nécessaire pour restaurer la paix familiale.

Origines : traumatismes, héritages, alliances invisibles

L'apparition du handicap spirituel n'est jamais fortuite. La MTHS identifie trois grandes origines :

1. Traumatismes individuels

Les événements traumatiques, qu'ils soient psychologiques, physiques ou spirituels, laissent une **empreinte durable sur le champ énergétique et symbolique de l'individu**. Par exemple, un enfant exposé à la violence domestique ou à des conflits occultes peut développer des comportements que la famille interprète comme sorcellerie. Dans ce cas, le handicap spirituel est la **manifestation inconsciente d'un traumatisme**, nécessitant un accompagnement intégratif : psychologique, rituel et éducatif.

2. Héritages transgénérationnels

Les lignées familiales transmettent parfois des pactes, malédictions ou obligations spirituelles non résolues. Ces héritages, conscients ou inconscients, peuvent **influencer les comportements, les choix et les relations** de l'individu. La MTHS observe que le sorcier hérité est souvent le porteur involontaire d'un déséquilibre ancestral, et que sa régulation passe par la **reconnaissance symbolique et le rituel de libération**.

3. Alliances invisibles et influences occultes

Certaines interactions spirituelles s'établissent en dehors de la conscience de l'individu, par le biais de pactes, d'entités ou de réseaux énergétiques complexes. Ces **alliances invisibles** peuvent amplifier ou déclencher des comportements perçus comme

sorcellerie. Le traitement MTHS inclut ici l'identification des liens invisibles, la dissociation des alliances problématiques et la mise en place de protections énergétiques et symboliques pour restaurer la stabilité.

Manifestations comportementales et relationnelles

Le handicap spirituel se traduit par une gamme **variée et complexe de comportements** qui affectent la vie quotidienne, les relations et la santé psychosomatique. Parmi les manifestations les plus fréquentes :

- **Comportements imprévisibles ou agressifs**, souvent interprétés comme malveillance.
- **Isolement social** ou difficulté à maintenir des relations harmonieuses.
- **Troubles psychosomatiques** : migraines, insomnies, fatigue chronique ou maladies récurrentes sans cause médicale apparente.
- **Incapacité à gérer le pouvoir ou l'énergie spirituelle**, qui se traduit par des effets négatifs sur les autres membres de la famille.

Ces manifestations ne sont pas uniformes : chaque handicap spirituel est **unique et contextuel**, lié à l'histoire personnelle, familiale et sociale de l'individu. La MTHS recommande une approche systémique, où chaque comportement est analysé dans son **contexte relationnel et symbolique**, pour éviter des interprétations simplistes qui peuvent aggraver les tensions.

Pourquoi le sorcier est souvent aussi une victime

L'un des postulats centraux de la MTHS est que **le sorcier est lui-même une victime**. Cette vision inverse le paradigme traditionnel : le sorcier n'est pas seulement un agent de mal ; il est aussi un sujet de souffrance, souvent invisible, dont les comportements destructeurs sont le **résultat d'un déséquilibre interne et d'un environnement familial ou social complexe**.

Cette victimisation peut être :

1. **Intra-personnelle** : stress, traumatisme, culpabilité ou incapacité à gérer ses facultés spirituelles.
2. **Interpersonnelle** : rejet familial, incompréhension sociale, accusations injustes.
3. **Transgénérationnelle** : héritage de pactes ou malédictions ancestrales.

Reconnaître le sorcier comme victime permet d'adopter une approche **humanisée et thérapeutique**, remplaçant la peur et la violence par le soin, la médiation et la régulation. Les interventions MTHS se concentrent donc sur la **restauration de l'équilibre et de la lucidité**, plutôt que sur la punition.

Cas cliniques illustratifs

Cas 1 : L'enfant traumatisé

Un garçon de 10 ans développe des crises d'angoisse inexplicables, que la famille interprète comme des manifestations de sorcellerie. L'évaluation MTHS révèle des traumatismes émotionnels liés à la perte d'un parent et à l'exposition à des disputes occultes. Le handicap spirituel se manifeste par des comportements

imprévisibles et une sensibilité extrême aux émotions des autres. Le traitement inclut : thérapie psychospirituelle, rituels de protection et médiation familiale. Après six mois, les crises diminuent et la perception de sorcellerie disparaît.

Cas 2 : L'adulte héritier

Une femme adulte est accusée d'avoir provoqué la maladie de son neveu. L'enquête MTHS montre un **handicap spirituel hérité**, lié à un pacte ancestral non régulé. Ses comportements, interprétés comme malveillants, sont involontaires. L'intervention combine : rituels de libération, accompagnement psychologique et éducation sur la régulation de son énergie spirituelle. La famille retrouve progressivement la confiance et la cohésion.

Cas 3 : L'adolescent et les alliances invisibles

Un adolescent urbain présente des accidents répétitifs et une agitation inexplicée. L'analyse MTHS révèle des **alliances invisibles** issues de jeux occultes et d'influences transgénérationnelles. Les interventions incluent : désactivation des liens énergétiques, rituels de purification et suivi éducatif. La manifestation du handicap spirituel diminue progressivement, et l'adolescent retrouve une vie sociale harmonieuse.

Conclusion

Ce chapitre a permis de **définir et de comprendre le handicap spirituel**, ses origines, ses manifestations et le rôle de la MTHS dans son traitement. Il a également déconstruit le stéréotype du sorcier exclusivement malveillant, en mettant en lumière sa **dimension de victime**.

La PARTIE II développe **les stratégies concrètes pour vivre-ensemble avec le sorcier**, à travers des protocoles de prévention, de médiation et de régulation familiale. La lecture clinique du handicap spirituel permet de **préparer le terrain pour une cohabitation pacifique**, fondée sur la lucidité, le soin et le respect des dynamiques symboliques et culturelles.

PARTIE- II :

LA FAMILLE SOUS TENSION SPIRITUELLE
Mécanismes des conflits et des blessures invisibles

CHAPITRE – 4 :

COMMENT LA SORCELLERIE DETRUIT LA PAIX FAMILIALE

Entrer dans la zone de fracture

Toute famille humaine repose sur un équilibre fragile : celui de la confiance partagée, de la reconnaissance mutuelle et de la transmission symbolique sécurisante. Lorsque la sorcellerie — réelle, supposée ou symboliquement intériorisée — s'introduit dans cet espace, elle agit comme un **agent de fracture systémique**. La paix familiale ne se brise pas brutalement ; elle se fissure lentement, à travers des soupçons discrets, des regards évités, des silences lourds, jusqu'à devenir une **tension spirituelle chronique**, invisible mais profondément destructrice.

La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS) observe que la sorcellerie familiale ne détruit pas seulement par les actes occultes attribués à tel ou tel membre ; elle détruit surtout par **les mécanismes psychospirituels qu'elle enclenche** : la suspicion permanente, la paranoïa collective, la désintégration de la confiance, la contamination émotionnelle des enfants, et la reproduction transgénérationnelle de la peur. Ce chapitre explore ces mécanismes dans leur chronologie, depuis la première fissure jusqu'à la division durable des lignées.

Suspicion permanente et paranoïa collective

La première blessure infligée par la sorcellerie à la famille est la **suspicion**. Elle naît rarement d'un événement isolé ; elle s'installe à partir d'une accumulation de faits interprétés : une maladie soudaine, un échec professionnel, une fausse couche, un accident inexpliqué. Dans un environnement culturel où le malheur ne peut être fortuit, la question surgit presque naturellement : *qui est derrière ?*

Cette question marque un point de non-retour. À partir de cet instant, la famille cesse d'être un espace neutre pour devenir un **terrain d'enquête invisible**. Chaque geste est interprété, chaque parole réévaluée, chaque succès suspecté. Le sourire devient masque, le silence devient aveu, la parole devient arme. La suspicion cesse d'être individuelle ; elle se diffuse et se transforme en **paranoïa collective**.

La paranoïa familiale fonctionne selon une logique circulaire : plus on soupçonne, plus on interprète, et plus les interprétations renforcent la certitude d'un danger occulte. La MTHS décrit ce phénomène comme une **pathologie systémique de la perception**, où la peur devient le filtre dominant de lecture du réel. Aucun événement ne peut plus être vécu simplement ; tout devient signe, message, attaque ou avertissement.

Dans ce climat, le sorcier présumé n'a même plus besoin d'agir. Sa simple existence suffit à entretenir l'angoisse. La

sorcellerie cesse alors d'être un acte pour devenir une **présence psychospirituelle permanente**, qui contamine l'ensemble du système familial.

Désintégration des liens de confiance

La suspicion chronique attaque directement le socle de la famille : la confiance. Or, la confiance familiale n'est pas un concept abstrait ; elle se manifeste concrètement dans les gestes quotidiens : manger ensemble sans crainte, confier ses enfants, partager ses projets, demander conseil, recevoir un don sans soupçon.

Lorsque la sorcellerie s'installe dans l'imaginaire familial, ces gestes deviennent impossibles. La nourriture est suspectée d'être empoisonnée spirituellement. Les cadeaux sont refusés ou détruits. Les conseils sont interprétés comme des pièges. La solidarité se transforme en **vulnérabilité dangereuse**.

Progressivement, les membres de la famille adoptent des stratégies de protection : distance émotionnelle, isolement volontaire, dissimulation de leurs réussites ou de leurs projets. La communication se fragmente ; chacun parle, mais personne n'écoute réellement. La famille existe encore biologiquement, mais elle est **spirituellement désintégrée**.

La MTHS insiste sur un point crucial : cette désintégration n'est pas seulement relationnelle ; elle est aussi **somatique et psychique**. Les corps réagissent à la perte de sécurité : troubles du sommeil, anxiété chronique, fatigue inexpliquée, maladies

psychosomatiques. La peur devient un stress permanent, et la famille se transforme en **espace pathogène**, là où elle devrait être un lieu de réparation.

Transmission de la peur aux enfants

L'un des effets les plus graves de la sorcellerie familiale est sa **transmission aux enfants**. Ceux-ci n'ont pas besoin d'être explicitement accusés ou menacés ; ils absorbent la peur à travers les attitudes, les silences, les interdictions implicites. L'enfant apprend très tôt à ne pas faire confiance, à se méfier des adultes, à interpréter le monde comme dangereux.

Dans les familles sous tension spirituelle, l'enfance perd son innocence symbolique. Les enfants deviennent des **vigiles émotionnels**, attentifs aux moindres signes de conflit invisible. Ils apprennent à se taire, à cacher leurs réussites, à redouter leurs propres rêves. Certains développent une hypervigilance anxieuse ; d'autres intériorisent la croyance qu'ils sont eux-mêmes porteurs d'un mal potentiel.

La MTHS observe que cette transmission de la peur constitue une **forme de violence invisible**, dont les effets se prolongent à l'âge adulte. Les enfants élevés dans un climat de sorcellerie non régulée présentent souvent :

- une difficulté à établir des relations de confiance,
- une tendance à l'auto-sabotage,
- une hypersensibilité aux conflits,

- ou, paradoxalement, une identification au rôle du sorcier ou de la victime.

Ainsi, la sorcellerie familiale ne détruit pas seulement le présent ; elle **programme le futur**, en inscrivant la peur dans la mémoire émotionnelle des générations suivantes.

Familles divisées sur plusieurs générations

Lorsque la sorcellerie n'est ni comprise ni soignée, elle produit son effet le plus durable : la **division transgénérationnelle**. Les conflits ne s'éteignent pas avec le temps ; ils se figent en récits, en alliances, en exclusions. Une branche familiale cesse de fréquenter une autre. Les mariages sont interdits. Les enfants héritent de conflits qu'ils n'ont jamais vécus, mais qu'ils portent comme une dette invisible.

La MTHS parle ici de **fracture lignagère**, un état dans lequel la famille cesse d'être une continuité symbolique pour devenir un champ de forces antagonistes. Chaque génération hérite non seulement d'un nom et d'un patrimoine, mais aussi d'une **peur héritée**, d'une méfiance structurante, parfois même d'un handicap spirituel transmis.

Dans ces familles divisées, la sorcellerie devient une **mémoire traumatique collective**. Elle structure les choix, les déplacements, les alliances sociales. Elle empêche la réconciliation, car toute tentative de rapprochement est vécue comme un risque mortel. Le passé ne passe pas ; il se répète.

Lecture clinique MTHS : de la destruction à la possibilité de soin

Face à ce tableau sombre, la MTHS ne se contente pas d'un constat. Elle propose une **lecture clinique** de la destruction familiale par la sorcellerie. Selon cette approche, la famille sous tension spirituelle est un **organisme blessé**, dont les symptômes (suspicion, division, transmission de la peur) sont les manifestations visibles d'un déséquilibre plus profond.

La sorcellerie, dans cette perspective, agit comme un **révéléateur** : elle met en lumière des traumatismes anciens, des non-dits, des rivalités non régulées, des héritages spirituels mal intégrés. Ce n'est pas la sorcellerie en elle-même qui détruit la famille, mais **l'absence de cadres de compréhension, de soin et de médiation**.

Comprendre comment la sorcellerie détruit la paix familiale est donc une étape indispensable pour envisager sa réparation. Tant que la peur gouverne, aucune guérison n'est possible. Tant que le sorcier est perçu uniquement comme un ennemi, la violence symbolique se perpétue. La MTHS invite à un renversement du regard : voir dans la tension spirituelle non pas une fatalité, mais un **appel au soin systémique**.

Conclusion

Ce chapitre a montré comment la sorcellerie infiltre la famille, détruit la confiance, traumatise les enfants et fracture les lignées. Il a mis en évidence que la paix familiale n'est pas seulement menacée par des actes occultes, mais par **les mécanismes psychospirituels de la peur non régulée**.

Les chapitres suivants entreront dans une phase décisive : **comment vivre-ensemble malgré la tension spirituelle**, comment protéger sans persécuter, comment soigner sans nier, comment reconstruire une famille capable de contenir ses blessures invisibles. Car là où la sorcellerie a semé la peur, la MTHS propose d'introduire la lucidité, le soin et la paix durable.

CHAPITRE-5 :

VICTIMES, ACCUSES ET BOUCS EMISSAIRES

De la désignation de l'ennemi intime à la clinique de la réparation familiale

Ouverture narrative : quand la famille cherche un coupable

Dans les familles traversées par la tension spirituelle, la souffrance ne circule jamais à l'état brut. Elle cherche un visage, un nom, une adresse. Elle se condense, se projette, se cristallise sur un être désigné. Ce processus, aussi ancien que les sociétés humaines, trouve dans les contextes africains contemporains une intensité particulière, nourrie par la précarité économique, la fragilisation des structures éducatives, la désorganisation des transmissions symboliques et l'intrusion de discours religieux radicalisés.

La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS) observe, depuis plusieurs décennies, que la majorité des conflits liés à la sorcellerie familiale ne relèvent pas d'une activité occulte objectivable, mais d'un **mécanisme de désignation sacrificielle**. Une famille en crise cherche à survivre psychiquement en identifiant un responsable de son malheur. C'est ainsi que naissent les figures de la victime, de l'accusé et du bouc émissaire, parfois réunies en une seule et même personne.

I. L'ENFANT, LA VEUVE, LE MALADE : CIBLES PRIVILEGIEES

1. La vulnérabilité comme critère d'accusation

Dans l'univers symbolique des familles en tension spirituelle, la vulnérabilité devient paradoxalement un signe de culpabilité. Celui qui ne peut se défendre, celui dont la parole est fragile, celui dont la position sociale est instable devient suspect. L'enfant, la veuve et le malade partagent une caractéristique commune : ils occupent une **zone de faiblesse relationnelle**.

La MTHS souligne ici une loi clinique constante : **plus un individu est dépendant du groupe, plus il est exposé à être accusé par ce groupe**. Cette dépendance crée une asymétrie de pouvoir qui facilite la projection des angoisses collectives.

2. L'enfant accusé : quand l'innocence devient une menace

L'enfant accusé de sorcellerie est l'une des figures les plus tragiques du paysage familial africain contemporain. Il n'est pas accusé parce qu'il fait le mal, mais parce qu'il dérange l'ordre symbolique. Un enfant trop intelligent, trop silencieux, trop rêveur, trop malade ou trop rebelle devient un écran de projection des peurs parentales.

Cliniquement, la MTHS observe que ces accusations émergent souvent dans des contextes de **défaillance parentale** : chômage, alcoolisme, conflits conjugaux, stérilité, deuils non élaborés. L'enfant est alors investi d'un pouvoir imaginaire

démessuré. On lui attribue la capacité de nuire parce que les adultes ont perdu la capacité de protéger.

Cette accusation a des effets dévastateurs : troubles anxieux précoces, dissociation psychique, troubles du sommeil, mutisme sélectif, comportements d'auto-dévalorisation. L'enfant finit par **intérioriser l'image du monstre** qu'on lui renvoie.

3. La veuve : mémoire vivante et cible idéale

La veuve incarne une autre figure centrale du bouc émissaire. Elle porte la mémoire du défunt, elle détient des secrets, elle occupe un espace ambigu entre appartenance et exclusion. Dans certaines configurations familiales, elle devient le symbole vivant de la perte, et donc de la colère collective.

La MTHS interprète ces accusations comme une tentative inconsciente d'effacer la douleur du deuil. En accusant la veuve d'avoir causé la mort de son époux, la famille évite d'affronter l'angoisse fondamentale de la finitude.

Les manifestations cliniques chez ces femmes sont récurrentes : dépression profonde, somatisations chroniques, troubles gynécologiques fonctionnels, perte de l'estime de soi, parfois idées suicidaires. Leur corps devient le lieu où s'inscrit la violence symbolique de l'exclusion.

4. Le malade : quand la souffrance dérange

Dans une famille déjà fragilisée, la maladie agit comme un révélateur. Elle rappelle la fragilité de la vie, la dépendance, l'impuissance. Le malade chronique, surtout lorsqu'il n'y a pas de diagnostic biomédical clair, devient suspect.

La MTHS parle ici de **renversement accusatoire** : au lieu de protéger le malade, la famille le rend responsable de sa propre souffrance et de celle des autres. La maladie est lue comme une preuve de sorcellerie, ou comme la conséquence d'une activité occulte.

Ce mécanisme aggrave le handicap spirituel du patient, en ajoutant à la douleur physique une culpabilité existentielle profonde.

II. VIOLENCE PSYCHOLOGIQUE ET EXCLUSIONS FAMILIALES

1. La violence invisible : mots, regards, silences

Contrairement à la violence physique, la violence psychologique ne laisse pas de traces visibles. Elle agit lentement, insidieusement, mais profondément. Elle se manifeste par des paroles humiliantes, des soupçons répétés, des regards accusateurs, des silences lourds de sens.

La MTHS identifie cette violence comme l'un des facteurs majeurs de désorganisation psychique dans les familles en tension spirituelle. Elle crée un climat de **surveillance permanente**, où chaque geste peut être interprété comme une preuve de culpabilité.

2. Exclusion progressive : de la table familiale à l'effacement social

L'exclusion ne survient jamais brutalement. Elle commence par une mise à distance symbolique : on ne partage plus les repas, on ne consulte plus la personne pour les décisions familiales, on ne l'invite plus aux cérémonies.

Progressivement, l'individu est **désaffilié**. Il cesse d'exister comme sujet relationnel. Cette exclusion produit des effets cliniques sévères : perte du sentiment d'identité, isolement social, troubles dépressifs majeurs, parfois passages à l'acte.

3. La famille comme espace de persécution

Lorsque la violence psychologique devient structurelle, la famille cesse d'être un espace de protection. Elle se transforme en lieu de persécution. Le sujet accusé vit dans une tension constante, anticipant l'accusation, redoutant le rejet.

La MTHS considère cette configuration comme une **urgence thérapeutique**, car elle peut conduire à des ruptures psychiques irréversibles.

III. LYNCHING SPIRITUEL ET RELIGIEUX

1. Quand le religieux légitime la violence

L'un des aspects les plus préoccupants observés par la MTHS est l'utilisation du discours religieux pour justifier l'exclusion et la violence. Des pratiques de délivrance mal encadrées, des prophéties accusatrices, des confessions forcées transforment la suspicion familiale en condamnation publique.

Le lynchage spirituel ne passe pas toujours par la mort physique. Il peut être symbolique : humiliation publique, exorcismes violents, privation de nourriture, enfermement, expulsion du domicile familial.

2. Confession forcée et destruction de l'identité

Sous la pression, certaines victimes finissent par avouer des faits qu'elles n'ont pas commis. Ces confessions ne sont pas des preuves, mais des **effondrements psychiques**. Elles marquent souvent le début d'un handicap spirituel durable.

La MTHS insiste : une confession obtenue sous contrainte n'a aucune valeur thérapeutique. Elle aggrave la fragmentation du sujet et renforce le pouvoir persécuteur du groupe.

3. Responsabilité éthique des leaders spirituels

Toute intervention religieuse dans un contexte de sorcellerie familiale engage une responsabilité majeure. Lorsqu'un leader spirituel valide l'accusation sans discernement clinique, il devient co-acteur du handicap spirituel.

La MTHS plaide pour une **alliance thérapeutique interdisciplinaire**, où le religieux, le thérapeute traditionnel et le clinicien travaillent à restaurer la dignité humaine, et non à désigner des coupables.

IV. ANALYSE CLINIQUE DE CAS REELS

Cas 1 : Enfant accusé après une série d'échecs familiaux

Un garçon de neuf ans est accusé d'être à l'origine des faillites successives de son père. Il présente des troubles du sommeil, des crises d'angoisse nocturnes, un mutisme partiel. L'analyse MTHS révèle un climat familial marqué par la honte sociale et l'effondrement de l'autorité paternelle.

L'intervention thérapeutique a consisté à **désamorcer la projection**, à restaurer la fonction parentale et à accompagner l'enfant dans un processus de réhabilitation symbolique.

Cas 2 : Veuve exclue après un décès brutal

Une femme de cinquante ans, accusée d'avoir « mangé » son mari, est chassée du domicile familial. Elle développe des douleurs chroniques diffuses et un état dépressif sévère. L'approche MTHS a mis en évidence un deuil collectif non élaboré et une lutte de pouvoir autour de l'héritage.

La prise en charge a combiné rituels de réparation, médiation familiale et accompagnement psychothérapeutique.

Cas 3 : Malade chronique devenu suspect

Un homme souffrant d'épilepsie est accusé de sorcellerie après plusieurs crises publiques. La famille interprète la maladie comme un signe d'activité occulte. La MTHS a travaillé à **re-symboliser la maladie**, à réintroduire une lecture non persécutrice du symptôme et à restaurer le lien familial.

CONCLUSION

Restaurer la dignité pour restaurer la paix

Ce chapitre révèle une vérité clinique fondamentale : **la sorcellerie familiale est souvent moins une affaire de pouvoir occulte que de souffrance humaine non reconnue**. Les victimes, les accusés et les boucs émissaires sont les révélateurs d'un système familial en crise.

La MTHS propose un renversement radical du regard : passer de l'accusation à la compréhension, de la persécution au soin, de la peur à la responsabilité collective. C'est à ce prix seulement que la paix familiale peut être restaurée, non comme absence de conflit, mais comme **présence de justice, de dignité et de lucidité partagée**.

CHAPITRE-6 :

QUAND LA RELIGION AGGRAVE LE CONFLIT

De la promesse de salut à la fabrication du traumatisme spirituel

INTRODUCTION

La religion appelée au chevet de la famille blessée

Lorsque la famille est déchirée par des conflits invisibles, lorsque la suspicion s'installe et que la parole ordinaire n'arrive plus à contenir la peur, la religion devient souvent le dernier recours. Elle est invoquée comme on appelle un médecin d'urgence : pour guérir, pour purifier, pour sauver. Dans l'imaginaire collectif africain, le religieux est porteur d'autorité, de sacré et de vérité ultime. Il est censé trancher là où les hommes hésitent, révéler là où les sens échouent.

Pourtant, l'observation clinique de la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS) montre une réalité plus ambivalente. Là où la religion devrait apaiser, elle exacerbe parfois. Là où elle devrait protéger les plus vulnérables, elle peut devenir un instrument de violence symbolique. Ce chapitre explore cette zone sensible où le religieux, mal compris ou mal exercé, cesse d'être un espace de guérison pour devenir un facteur d'aggravation du conflit familial.

Il ne s'agit pas ici de condamner la religion en tant que telle, mais d'analyser les **dérives cliniques et éthiques** de certaines pratiques spirituelles lorsqu'elles interviennent dans des contextes de sorcellerie familiale sans discernement thérapeutique.

I. LES DISCOURS DE DELIVRANCE VIOLENTE : QUAND LE SOIN DEVIENT AGRESSION

1. La délivrance comme réponse immédiate à la peur

Dans de nombreuses familles, l'accusation de sorcellerie conduit presque automatiquement à la recherche d'une séance de délivrance. Cette pratique, présentée comme une libération du mal, repose sur une vision dualiste du monde : d'un côté Dieu et le bien, de l'autre le démon et le mal. L'individu suspecté est alors perçu comme un champ de bataille spirituel.

La MTHS observe que cette logique de la délivrance immédiate répond moins à un besoin thérapeutique qu'à une **urgence émotionnelle collective**. La famille, submergée par la peur, cherche une solution rapide, spectaculaire, qui donne l'illusion du contrôle. Le rituel devient alors un exutoire à l'angoisse plus qu'un acte de soin.

2. Violence rituelle et effraction psychique

Dans sa forme violente, la délivrance se caractérise par des cris, des injonctions autoritaires, des menaces spirituelles, parfois des contraintes physiques. Le corps du supposé sorcier est traité comme un objet à neutraliser, non comme un sujet à comprendre. Cette effraction brutale dans l'intimité psychique produit des effets traumatiques durables.

Cliniquement, la MTHS relève chez les victimes de ces pratiques des symptômes comparables à ceux observés dans les traumatismes complexes : dissociation, amnésie partielle, cauchemars récurrents, hypervigilance, sentiment de honte chronique. La délivrance, censée libérer, devient une **expérience d'intrusion violente**, parfois plus destructrice que le conflit initial.

3. La mise en scène du mal et la théâtralisation de la souffrance

Les discours de délivrance violente reposent souvent sur une scénographie du mal. Le corps qui tremble, la voix qui change, la chute au sol sont interprétés comme des preuves irréfutables de possession. Or, la MTHS rappelle que ces manifestations peuvent être induites par la suggestion, la pression psychologique et le contexte émotionnel intense.

Le danger clinique réside dans la confusion entre **réaction psychotraumatique** et **activité spirituelle malveillante**. En interprétant toute manifestation de détresse comme un signe de sorcellerie, le discours religieux enferme le sujet dans une identité pathologisée dont il devient prisonnier.

II. CONFUSION ENTRE DISCERNEMENT ET ACCUSATION

1. Le discernement spirituel : une fonction dévoyée

Le discernement, dans sa définition théologique authentique, est une capacité de lecture fine des situations humaines, impliquant humilité, prudence et écoute. Pourtant, dans de nombreux

contextes familiaux, ce terme est utilisé pour justifier des accusations sans fondement clinique.

La MTHS constate que le discernement est souvent réduit à une **intuition subjective sacralisée**. Une impression devient une révélation, un soupçon devient une certitude. Le leader spirituel, persuadé d'agir au nom d'une vérité supérieure, ne se sent plus tenu par les règles élémentaires de la prudence humaine.

2. L'accusation comme pseudo-vérité révélée

Lorsque l'accusation est présentée comme le fruit d'un discernement spirituel, elle acquiert une force redoutable. Elle ne peut plus être discutée, car la contester revient à s'opposer à Dieu lui-même. Cette sacralisation de l'accusation supprime toute possibilité de défense pour la personne visée. Cliniquement, cette situation entraîne un **effondrement du sujet accusé**. Il se retrouve pris dans un piège paradoxal : s'il nie, il est coupable ; s'il accepte, il se détruit. La MTHS considère cette configuration comme l'une des plus toxiques pour la santé psychique.

3. La disparition du doute : signe d'un abus spirituel

Le doute est une composante essentielle de toute démarche authentiquement spirituelle. Lorsqu'il disparaît au profit d'une certitude accusatrice absolue, le religieux bascule dans l'abus. La MTHS insiste : **là où il n'y a plus de doute, il n'y a plus de soin possible.**

III. ABUS SPIRITUELS ET TRAUMATISMES RELIGIEUX

1. Définition clinique de l'abus spirituel

L'abus spirituel se produit lorsque l'autorité religieuse est utilisée pour contrôler, humilier ou détruire psychiquement un individu au nom du sacré. Dans les contextes de sorcellerie familiale, cet abus prend souvent la forme d'accusations publiques, de confessions forcées, de rituels humiliants.

La MTHS considère l'abus spirituel comme une **cause majeure de handicap spirituel acquis**. Il altère durablement la relation du sujet à lui-même, aux autres et au divin.

2. Les blessures invisibles de la foi

Les traumatismes religieux sont particulièrement profonds car ils touchent le noyau existentiel de la personne. La foi, qui devrait être une source de consolation, devient un lieu de terreur. Dieu est perçu comme un juge implacable plutôt que comme une présence bienveillante.

Les patients suivis en MTHS après des abus spirituels présentent souvent une ambivalence douloureuse : ils aspirent à la foi tout en la redoutant. Cette tension interne se manifeste par des troubles anxieux, des crises de panique lors des prières, une culpabilité chronique et un sentiment d'indignité spirituelle.

3. Transmission transgénérationnelle du traumatisme religieux

Un aspect souvent négligé est la transmission du traumatisme religieux aux générations suivantes. Les enfants témoins de violences spirituelles intègrent très tôt une représentation menaçante du religieux. Ils apprennent que la foi peut détruire, exclure, humilier.

La MTHS observe que ces enfants développent soit un rejet radical de toute spiritualité, soit une soumission excessive à des figures religieuses autoritaires, reproduisant ainsi le cycle de la violence symbolique.

IV. RESPONSABILITE DES LEADERS SPIRITUELS

1. Le leader spirituel comme acteur thérapeutique potentiel

Dans de nombreuses familles africaines, le leader spirituel occupe une place centrale. Sa parole a un poids considérable. À ce titre, il est de facto un **acteur thérapeutique**, qu'il en ait conscience ou non. Cette position implique une responsabilité éthique majeure.

La MTHS affirme que tout leader spirituel intervenant dans un conflit familial lié à la sorcellerie devrait se considérer comme un **soignant de l'âme**, et non comme un juge ou un procureur.

2. Les dérives de pouvoir et la tentation de l'omniscience

Le danger principal réside dans la tentation de l'omniscience spirituelle. Lorsque le leader se perçoit comme détenteur exclusif de la vérité divine, il cesse d'écouter. Il impose. Il tranche. Cette posture nourrit les abus et détruit la confiance.

Cliniquement, la MTHS identifie ces situations comme des **configurations de domination spirituelle**, proches des mécanismes sectaires, même lorsqu'elles se déploient dans des cadres religieux socialement reconnus.

3. Vers une éthique spirituelle du soin

Face à ces dérives, la MTHS propose une éthique spirituelle fondée sur quatre principes : la prudence, la compassion, la collaboration interdisciplinaire et le respect absolu de la dignité humaine. Le leader spirituel n'est pas appelé à tout résoudre seul, mais à orienter, à apaiser, à protéger les plus vulnérables.

Refuser d'accuser sans preuve clinique, refuser les confessions forcées, refuser la violence rituelle : ces refus ne sont pas des signes de faiblesse spirituelle, mais des marques de maturité éthique.

CONCLUSION

Réconcilier foi et humanité

Ce chapitre met en lumière une réalité douloureuse : la religion, lorsqu'elle se détache de l'écoute humaine et du discernement clinique, peut devenir un facteur majeur de désintégration familiale. Mais il révèle aussi une espérance : celle d'une spiritualité réconciliée avec la dignité humaine.

La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels ne s'oppose pas à la foi. Elle l'invite à se purifier de ses violences, à redevenir un espace de réparation plutôt que de condamnation. Là où la religion choisit d'écouter avant d'accuser, de soigner avant de juger, elle redevient ce qu'elle n'aurait jamais dû cesser d'être : **un chemin de paix, même au cœur des familles les plus blessées.**

PARTIE-III :
VIVRE-ENSEMBLE SANS SE DÉTRUIRE
Stratégies cliniques et relationnelles de paix

CHAPITRE-7 :

PEUT-ON VIVRE AVEC UN SORCIER DANS LA MEME FAMILLE ?

INTRODUCTION :

La question qui fracture les familles africaines

Dans les sociétés africaines contemporaines, rares sont les questions qui provoquent autant de silences lourds, de tensions larvées et de fractures irréversibles que celle-ci : *peut-on vivre avec un sorcier dans la même famille ?* Cette interrogation n'est ni marginale ni folklorique. Elle surgit au cœur des maisons, traverse les lignées, s'infiltré dans les relations conjugales, déchire les fratries et reconfigure parfois durablement l'architecture émotionnelle et spirituelle des familles.

À la différence des sociétés occidentales, où le conflit familial se pense majoritairement en termes psychologiques ou juridiques, le contexte africain intègre une **dimension invisible**, symbolique et spirituelle qui structure la lecture des événements. La maladie inexplicable, l'échec répétitif, la mort prématurée, la stérilité, la ruine économique ou les troubles mentaux sont fréquemment interprétés comme les manifestations d'une **agression spirituelle intrafamiliale**, attribuée à un membre perçu comme sorcier.

Face à cette réalité, deux attitudes extrêmes dominent le débat social : d'un côté, la négation radicale du phénomène au nom d'une modernité désincarnée ; de l'autre, la diabolisation

systématique, souvent encouragée par des discours religieux violents, qui transforme le soupçon en condamnation et la peur en persécution.

La **Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS)** propose une troisième voie : une réponse **clinique, réaliste et humanisante**, qui refuse à la fois l'angélisme naïf et la chasse aux sorciers. Elle pose la question non pas en termes de croyance abstraite, mais de **cohabitation thérapeutique**, de **sécurité psychique**, de **limites relationnelles** et de **préservation de la paix familiale**.

I. REPONSE CLINIQUE ET REALISTE DE LA MTHS : SORTIR DU FANTASME ET DU DENI

La première contribution majeure de la MTHS consiste à déplacer la question du registre moral vers le registre clinique. Demander si l'on peut vivre avec un sorcier n'implique pas de statuer sur la culpabilité métaphysique d'un individu, mais d'évaluer **l'impact réel et mesurable de la relation** sur la santé globale des membres de la famille.

Dans l'approche MTHS, le terme *sorcier* ne désigne pas prioritairement un criminel spirituel conscient, mais un **handicapé spirituel**, c'est-à-dire une personne dont l'histoire, les traumatismes, les blessures transgénérationnelles ou les initiations subies ont altéré la capacité à établir des relations non prédatrices. La sorcellerie est alors comprise comme une **pathologie relationnelle de l'invisible**, souvent inconsciente, enracinée dans la souffrance plus que dans la malveillance.

Cette perspective clinique impose une rupture radicale avec les discours de délivrance violente qui prospèrent sur la peur. Elle rappelle une vérité fondamentale : **toute famille est un système**, et dans tout système, la pathologie n'est jamais isolée. Le sorcier présumé n'est pas toujours l'origine unique du mal, mais parfois le **symptôme visible d'un dysfonctionnement collectif ancien**.

Vivre avec un tel individu devient alors une question d'**évaluation thérapeutique** :

- La relation est-elle destructrice ou simplement inconfortable ?
- Les frontières psychiques sont-elles respectées ?
- Les manifestations de nuisance sont-elles actives, répétitives et ciblées ?
- Existe-t-il une possibilité de régulation, de médiation ou de protection ?

La MTHS affirme clairement : **oui, il est parfois possible de vivre avec un handicapé spirituel dans la même famille**, mais **non, ce n'est ni automatique ni obligatoire**. La cohabitation n'est jamais un impératif moral, encore moins spirituel. Elle est une option conditionnelle, soumise à des critères précis de sécurité intérieure.

II. COHABITATION ET SOUMISSION : UNE CONFUSION MORTIFERE

L'un des apports les plus décisifs de la MTHS est la distinction rigoureuse entre **cohabitation** et **soumission**. Dans de nombreuses familles, cette confusion produit des dégâts

considérables, car elle pousse les victimes à endurer l'inacceptable au nom de la paix, de la foi ou du respect des aînés.

La cohabitation thérapeutique est un **choix conscient**, structuré, encadré par des limites claires. Elle suppose que chacun conserve son intégrité psychique, son libre arbitre et sa capacité à se protéger. La soumission, en revanche, est une **abdication intérieure**, un effacement progressif de soi, souvent justifié par des discours religieux culpabilisants : *supporte, pardonne, endure, prie davantage*.

Cliniquement, la soumission prolongée à une relation spirituellement toxique entraîne des symptômes bien documentés : troubles anxieux chroniques, dépression résistante, somatisations, dissociation, perte de vitalité, confusion identitaire et parfois effondrement spirituel. La MTHS considère ces manifestations comme des **signaux d'alarme thérapeutiques**, et non comme des épreuves spirituelles méritoires.

Il est donc essentiel d'affirmer une vérité souvent taboue : **Dieu ne demande jamais à une personne de se laisser détruire pour sauver une relation familiale**. La paix authentique ne se construit pas sur le sacrifice de la santé mentale et spirituelle d'un individu.

Vivre ensemble sans se détruire implique de reconnaître que certaines formes de proximité deviennent, à un moment donné,

pathogènes. La sagesse clinique consiste alors à ajuster la distance, non par haine ou rejet, mais par souci de préservation.

III. LIMITES SAINES ET PROTECTIONS SPIRITUELLES : L'ARCHITECTURE INVISIBLE DE LA PAIX

Lorsque la cohabitation est jugée possible, elle ne peut s'envisager sans la mise en place de **limites saines** et de **protections spirituelles adaptées**. Ces deux dimensions constituent l'architecture invisible de la paix familiale durable.

Les limites saines ne sont pas des murs de rejet, mais des **frontières fonctionnelles**. Elles organisent l'espace relationnel de manière à réduire les zones de friction et de prédation. Concrètement, cela peut impliquer :

- une gestion séparée de certains espaces intimes,
- une limitation des échanges émotionnels profonds,
- une clarification des rôles et des responsabilités,
- une réduction des dépendances affectives ou matérielles.

Sur le plan spirituel, la MTHS distingue soigneusement la **protection** de la **contre-attaque**. Là où certaines pratiques religieuses encouragent l'agression symbolique ou la guerre spirituelle permanente, la MTHS privilégie des protocoles de **stabilisation**, d'**enracinement** et de **fermeture des brèches**. Il s'agit moins de combattre que de **se rendre non accessible à la nuisance**.

Cette protection repose sur plusieurs piliers :

- l’ancrage identitaire et spirituel,
- la cohérence entre croyances et pratiques,
- l’hygiène relationnelle et émotionnelle,
- le travail de guérison des traumatismes anciens.

Une famille protégée n’est pas une famille paranoïaque. C’est une famille qui connaît ses vulnérabilités et qui a appris à **ne plus les exposer inutilement**.

IV. QUAND LA DISTANCE DEVIENT THERAPEUTIQUE

Il existe cependant des situations où, malgré les efforts, les limites et les protections, la cohabitation demeure dangereuse. La MTHS nomme alors une réalité souvent culpabilisante : **la distance peut être thérapeutique**. Dans certains cas, la proximité constante avec un handicapé spirituel non conscientisé ou non stabilisé agit comme un **facteur de rechute chronique**. Les symptômes persistent, les attaques se répètent, la peur s’installe, et la vie devient un champ de tension permanent. Continuer à vivre ensemble dans ces conditions ne relève plus de la vertu, mais de l’acharnement destructeur.

La distance thérapeutique n’est ni une rupture affective définitive ni une condamnation morale. Elle est un **dispositif de soin**, comparable à l’isolement temporaire en médecine somatique lorsqu’un agent pathogène met en danger l’organisme. Elle permet :

- la restauration des forces vitales,
- la reconstruction psychique,
- la clarification des responsabilités,
- parfois même, paradoxalement, une amélioration ultérieure de la relation.

La MTHS insiste sur un point crucial : **s'éloigner pour se sauver n'est pas trahir sa famille**. C'est souvent la seule manière de briser les cycles de violence invisible qui se transmettent de génération en génération.

CONCLUSION

Une sagesse de la mesure et de la vie

À la question *peut-on vivre avec un sorcier dans la même famille ?*, la MTHS refuse les réponses simplistes. Elle propose une sagesse de la **mesure**, du **discernement clinique** et du **respect de la vie** sous toutes ses formes.

Oui, certaines cohabitations sont possibles, à condition qu'elles soient choisies, encadrées et protégées. Non, aucune personne n'est tenue de se sacrifier sur l'autel d'une paix illusoire. Entre la peur et le déni, entre la violence et la naïveté, il existe un chemin étroit : celui d'un vivre-ensemble lucide, responsable et profondément humain.

Vivre ensemble sans se détruire n'est pas une utopie morale. C'est une **discipline relationnelle**, un art fragile, exigeant, qui commence toujours par une vérité essentielle : **la paix familiale ne vaut que si elle préserve la vie intérieure de chacun**.

CHAPITRE- 8 :

PROTEGER LA FAMILLE SANS PERSECUTER

INTRODUCTION

Quand la protection devient violence

Dans l'histoire intime des familles africaines, la volonté de protéger les siens est l'un des moteurs les plus puissants de l'action humaine. Elle naît d'un instinct ancestral : préserver la vie, maintenir la lignée, assurer la continuité. Pourtant, ce même désir de protection, lorsqu'il est mal orienté, mal compris ou instrumentalisé par la peur, peut devenir le terreau de violences sourdes, de persécutions injustifiées et de traumatismes durables.

Protéger la famille sans persécuter constitue ainsi l'un des défis majeurs de la clinique spirituelle contemporaine. Trop souvent, la protection est confondue avec l'attaque préventive, la vigilance avec la suspicion permanente, la foi avec la chasse aux ennemis invisibles. Dans ces contextes, la famille cesse d'être un espace de refuge pour devenir un champ de bataille, où chacun se surveille, se méfie et s'épuise.

La **Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS)** s'inscrit résolument à contre-courant de ces dérives. Elle propose une vision de la protection fondée non sur la persécution, mais sur la **stabilisation**, la **cohérence intérieure** et la **prévention non violente**. Protéger, dans cette approche, ne signifie jamais détruire l'autre, mais **réduire les vulnérabilités du système**

familial afin que les agressions, qu'elles soient réelles ou fantasmées, perdent leur pouvoir de nuisance.

Ce chapitre explore cette voie étroite mais essentielle, en articulant quatre axes fondamentaux : l'hygiène spirituelle familiale, les rituels de protection non violents, le rôle du silence, de la prière et de la vigilance, et enfin les pratiques qu'il ne faut jamais adopter, car elles détruisent ce qu'elles prétendent défendre.

I. L'HYGIENE SPIRITUELLE FAMILIALE : UNE PREVENTION CLINIQUE DE L'INVISIBLE

Dans le champ de la MTHS, l'hygiène spirituelle familiale occupe une place comparable à celle de l'hygiène corporelle en médecine somatique. Elle ne vise pas à répondre à une crise aiguë, mais à **prévenir l'installation des déséquilibres**. Pourtant, cette notion reste largement incomprise, souvent réduite à des pratiques magico-religieuses répétitives ou à des rituels mécaniques vidés de sens.

Scientifiquement, l'hygiène spirituelle peut être définie comme l'ensemble des **pratiques régulières qui maintiennent la cohérence psychique, émotionnelle, relationnelle et spirituelle d'un système familial**. Elle agit en amont des conflits ouverts, en renforçant les mécanismes naturels d'autorégulation.

Une famille spirituellement hygiénique est avant tout une famille où les tensions sont nommées, où les conflits ne sont pas niés, où les non-dits ne s'accumulent pas jusqu'à devenir toxiques. La MTHS insiste sur un point crucial : **les brèches spirituelles ne**

s'ouvrent pas seulement par des attaques extérieures, mais surtout par des fissures intérieures. Les rancœurs prolongées, les jalousies silencieuses, les humiliations répétées, les injustices non réparées constituent autant de portes ouvertes à la dégradation du climat familial.

L'hygiène spirituelle commence donc par des gestes simples, mais exigeants : la régulation des émotions, le respect des limites individuelles, la reconnaissance des blessures passées. Elle suppose également une cohérence entre le discours spirituel et les comportements quotidiens. Une famille qui prie ensemble mais s'humilie mutuellement entretient une dissonance profonde, génératrice de confusion et de vulnérabilité.

Dans cette perspective, la protection n'est pas un acte ponctuel déclenché par la peur, mais un **processus continu**, discret, presque invisible, qui rend la famille moins perméable aux dynamiques destructrices.

II. RITUELS DE PROTECTION NON VIOLENTS : RESTAURER SANS ATTAQUER

Lorsque la prévention ne suffit plus et que la famille ressent le besoin de renforcer sa protection, la question des rituels se pose inévitablement. Or, c'est précisément à ce stade que de nombreuses dérives apparaissent. Dans l'imaginaire collectif, protéger signifie souvent **neutraliser un ennemi**, identifié ou supposé. Cette logique guerrière, transposée dans le champ

spirituel, produit des rituels violents, accusatoires et profondément traumatisants.

La MTHS opère ici une distinction fondamentale entre **rituels de restauration** et **rituels de confrontation**. Les premiers visent à renforcer l'intégrité du système familial ; les seconds cherchent à détruire, exposer ou humilier un adversaire désigné. Seuls les rituels de restauration sont considérés comme thérapeutiques.

Un rituel de protection non violent ne s'adresse jamais directement à un agresseur présumé. Il agit sur la famille elle-même, sur ses fondations invisibles. Il peut prendre la forme de temps symboliques de réconciliation, de purification des espaces de vie, de redéfinition des alliances familiales, ou de réappropriation consciente de l'histoire transgénérationnelle.

Cliniquement, ces rituels ont un effet mesurable : ils réduisent l'anxiété collective, restaurent le sentiment de sécurité intérieure et diminuent les comportements paranoïaques. Ils permettent à la famille de sortir de l'hypervigilance permanente, état épuisant qui affaiblit paradoxalement les défenses psychiques.

La non-violence rituelle n'est pas une faiblesse. Elle repose sur une compréhension fine des mécanismes de projection : **attaquer un ennemi invisible, c'est souvent renforcer sa présence psychique**. À l'inverse, restaurer la stabilité interne rend progressivement les attaques inopérantes.

III. LE ROLE DU SILENCE, DE LA PRIERE ET DE LA VIGILANCE : UNE TRIADE THERAPEUTIQUE

Dans une culture marquée par la parole incantatoire, la dénonciation publique et l'exposition spectaculaire du mal, le silence est souvent perçu comme une complicité. La MTHS propose une lecture radicalement différente : **le silence peut être un acte thérapeutique majeur**, à condition qu'il soit conscient et structuré.

Le silence clinique n'est ni le déni ni la fuite. Il s'agit d'un silence stratégique, qui empêche la propagation de la peur, limite les interprétations abusives et protège les membres les plus vulnérables de la famille, notamment les enfants. Trop de familles détruisent leur propre équilibre en parlant excessivement du danger, en nommant sans cesse des menaces hypothétiques, en alimentant un climat d'angoisse chronique.

La prière, dans l'approche MTHS, n'est pas conçue comme une arme offensive, mais comme un **outil de recentrage intérieur**. Elle vise à restaurer l'alignement entre l'intention, la parole et l'action. Une prière authentiquement thérapeutique apaise, clarifie et unifie. Elle ne désigne pas de coupables, ne réclame pas de représailles, ne nourrit pas la haine.

Associée au silence et à la prière, la vigilance constitue le troisième pilier de cette triade. Vigilance ne signifie pas suspicion permanente, mais **attention lucide aux signaux faibles** : changements de comportement, fatigue excessive, conflits récurrents, troubles émotionnels inexplicables. Une famille vigilante

intervient tôt, avant que la situation ne se cristallise en conflit ouvert ou en persécution.

Cette triade (silence, prière, vigilance) agit comme un système immunitaire spirituel. Elle protège sans agresser, prévient sans accuser, stabilise sans enfermer.

IV. CE QU'IL NE FAUT JAMAIS FAIRE : LES ERREURS IRREVERSIBLES

Toute clinique sérieuse se définit autant par ce qu'elle recommande que par ce qu'elle interdit. Dans le domaine de la protection familiale, certaines pratiques sont unanimement considérées par la MTHS comme **contre-thérapeutiques**, voire dangereuses.

La première est l'accusation publique sans preuve clinique. Désigner un membre de la famille comme sorcier, surtout devant des tiers ou des autorités religieuses, constitue une violence symbolique majeure. Les effets psychiques de telles accusations sont comparables à ceux des traumatismes graves : honte toxique, isolement social, effondrement identitaire, parfois passage à l'acte suicidaire.

La seconde erreur consiste à soumettre la famille à des rituels violents répétés, censés « purifier » ou « délivrer ». Ces pratiques, souvent spectaculaires, créent une dépendance à la peur et renforcent la croyance que le mal est omniprésent. Cliniquement, elles aggravent les troubles anxieux et fragmentent durablement les liens familiaux.

Il ne faut jamais non plus instrumentaliser les enfants comme témoins, accusateurs ou intercesseurs. Les exposer à des discours de guerre spirituelle perturbe leur développement psychique et installe des schémas de peur durablement ancrés.

Enfin, l'une des erreurs les plus graves consiste à confondre protection et vengeance. Dès que la protection vise à punir, humilier ou exclure définitivement, elle cesse d'être thérapeutique. Elle devient une reproduction du mal qu'elle prétend combattre.

CONCLUSION :

Protéger la vie avant de combattre le mal

Protéger la famille sans persécuter exige une maturité rare, une capacité à résister à la peur collective et aux discours simplistes. La MTHS propose une éthique de la protection fondée sur la **préservation de la vie psychique, relationnelle et spirituelle** de tous les membres de la famille, y compris les plus fragiles.

Dans cette perspective, la véritable protection ne fait pas de bruit. Elle s'installe dans la durée, se nourrit de cohérence, de sobriété et de discernement. Elle refuse la violence même lorsqu'elle est justifiée par la foi. Elle choisit la guérison plutôt que la guerre, la stabilisation plutôt que l'exclusion.

Ainsi, protéger la famille sans persécuter n'est pas une naïveté spirituelle. C'est une **science de l'invisible**, une discipline exigeante, qui reconnaît que la paix véritable commence toujours par la responsabilité intérieure, et que l'on ne sauve jamais une famille en la transformant en tribunal.

CHAPITRE-9 :

PARLER SANS ACCUSER : COMMUNICATION THERAPEUTIQUE

INTRODUCTION :

Quand la parole devient un lieu de guérison ou de mort

Dans toutes les cultures humaines, la parole n'est jamais neutre. Elle soigne ou elle blesse, elle relie ou elle fracture, elle éclaire ou elle condamne. En contexte familial africain, cette ambivalence de la parole est encore plus marquée, car elle est investie d'une **puissance symbolique et spirituelle** qui dépasse largement sa fonction communicative. Parler, ici, c'est nommer le réel, mais aussi parfois le créer.

Au fil des chapitres précédents, une évidence s'est imposée : la majorité des drames familiaux liés aux accusations de sorcellerie, aux conflits spirituels et aux ruptures intergénérationnelles ne naissent pas uniquement des faits invisibles eux-mêmes, mais de la **manière dont on en parle**. La parole, mal maîtrisée, devient un instrument de persécution. La parole, travaillée cliniquement, peut devenir un **outil thérapeutique majeur**.

La **Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS)** accorde à la communication une place centrale. Elle ne considère pas la parole comme un simple échange d'informations, mais comme un **acte clinique**, capable de modifier en profondeur les équilibres psychiques, relationnels et spirituels d'un système familial. Parler sans accuser n'est pas un exercice de diplomatie

superficielle ; c'est une **discipline intérieure**, une science de la relation, un art de la responsabilité.

Ce chapitre explore cette science de la parole thérapeutique en quatre temps : comprendre la différence entre la parole qui apaise et celle qui détruit, apprendre à gérer les conflits spirituels en famille, redécouvrir la médiation traditionnelle et spirituelle, et enfin restaurer le dialogue intergénérationnel, souvent brisé par des décennies de silences, de peurs et de malentendus.

I. LA PAROLE QUI APAISE ET CELLE QUI DETRUIT : UNE CLINIQUE DU VERBE

La première étape d'une communication thérapeutique consiste à reconnaître que **toutes les paroles n'ont pas le même effet clinique**. Certaines paroles apaisent même lorsqu'elles sont difficiles à entendre ; d'autres détruisent même lorsqu'elles se présentent comme des vérités nécessaires. Cette distinction est fondamentale dans la MTHS.

La parole qui détruit est généralement **accusatoire, définitive et désincarnée**. Elle réduit l'autre à un rôle (*agresseur, sorcier, ennemi, cause du mal*) et lui retire toute complexité humaine. Elle se nourrit de certitudes absolues, ne laisse aucune place au doute, et transforme la relation en procès permanent. Cliniquement, ce type de parole déclenche des mécanismes de défense violents : déni, fuite, agressivité, effondrement psychique ou passage à l'acte.

À l'inverse, la parole qui apaise n'est pas nécessairement douce ou complaisante. Elle peut être ferme, exigeante, parfois douloureuse, mais elle respecte une règle fondamentale : **elle parle de l'impact sans figer l'identité**. Elle décrit des faits, des ressentis, des conséquences, sans enfermer l'autre dans une étiquette irréversible. Elle ouvre un espace de responsabilité sans prononcer de condamnation.

La MTHS insiste sur un principe clé : **on ne soigne pas un système familial en désignant des coupables, mais en nommant des dynamiques**. Dire « *je souffre de ce que je vis avec toi* » n'a pas le même effet clinique que dire « *tu es la cause de tout* ». La première phrase ouvre un espace de travail ; la seconde ferme toute possibilité de réparation.

Dans les familles marquées par la peur spirituelle, la parole destructrice se propage souvent plus vite que la parole apaisante, car elle donne l'illusion de contrôler l'invisible. Pourtant, à long terme, elle fragilise l'ensemble du système. Apprendre à parler sans accuser, c'est accepter de **renoncer à la toute-puissance de la parole violente** au profit d'une parole plus humble, mais infiniment plus réparatrice.

II. GESTION DES CONFLITS SPIRITUELS EN FAMILLE : DU SOUPÇON AU DISCERNEMENT

Les conflits spirituels occupent une place particulière dans la clinique familiale africaine. Ils ne portent pas seulement sur des comportements observables, mais sur des intentions supposées, des forces invisibles, des héritages transgénérationnels. Cette spécificité rend leur gestion particulièrement délicate, car le terrain est propice aux interprétations abusives et aux escalades émotionnelles.

La MTHS propose de déplacer le conflit du registre du **soupçon** vers celui du **discernement clinique**. Le soupçon est diffus, anxiogène et contagieux. Il transforme chaque événement négatif en preuve supplémentaire d'une hostilité cachée. Le discernement, en revanche, est lent, méthodique et contextualisé. Il distingue ce qui relève du conflit relationnel ordinaire, de la projection émotionnelle, de la souffrance psychique ou d'un réel déséquilibre spirituel.

Dans la gestion thérapeutique des conflits spirituels, la parole joue un rôle central. Elle doit être **contenante**, c'est-à-dire capable d'accueillir l'angoisse sans la nourrir. Parler trop vite, trop fort ou trop publiquement aggrave presque toujours la situation. La MTHS recommande des espaces de parole restreints, sécurisés, où les émotions peuvent être exprimées sans être immédiatement interprétées comme des preuves d'agression.

Un autre principe fondamental est la **temporalité**. Les conflits spirituels exigent du temps. Chercher une résolution immédiate conduit souvent à des décisions irréversibles prises sous l'emprise de la peur. La parole thérapeutique accepte l'inconfort de l'incertitude, elle suspend le jugement, elle laisse émerger progressivement une compréhension plus fine de la situation.

Gérer un conflit spirituel en famille, ce n'est donc pas trancher rapidement entre le vrai et le faux, le bien et le mal, mais **maintenir un espace relationnel suffisamment stable pour que la vérité puisse émerger sans détruire les personnes.**

III. MEDIATION TRADITIONNELLE ET SPIRITUELLE : SAGESSE ANCIENNE ET CLINIQUE CONTEMPORAINE

Avant l'irruption des discours religieux radicalisés et des modèles judiciaires importés, les sociétés africaines avaient développé des **formes sophistiquées de médiation** pour gérer les conflits familiaux et communautaires. La MTHS ne les idéalise pas, mais reconnaît leur pertinence clinique lorsqu'elles sont réinterprétées à la lumière des connaissances contemporaines.

La médiation traditionnelle repose sur plusieurs piliers : la lenteur, la symbolisation, la parole indirecte et la présence d'un tiers reconnu. Contrairement aux confrontations modernes, souvent frontales et humiliantes, la médiation traditionnelle cherche à **sauver la relation avant de sauver la vérité**. Elle permet aux protagonistes de parler sans se détruire, parfois même sans se regarder directement.

La médiation spirituelle, dans l'approche MTHS, ne consiste pas à exorciser ou à accuser, mais à **réharmoniser**. Elle reconnaît que certains conflits dépassent les individus et s'inscrivent dans des histoires transgénérationnelles complexes. Le médiateur n'est pas un juge, mais un **gardien du cadre**, chargé de contenir la parole, de ralentir les escalades et de rappeler les limites.

Cliniquement, la médiation agit comme un **tiers régulateur** qui empêche la fusion émotionnelle et la violence symbolique. Elle offre un espace où la parole peut circuler sans se transformer en arme. Lorsqu'elle est bien conduite, elle permet souvent d'éviter des ruptures définitives et des traumatismes durables.

La MTHS insiste toutefois sur un point crucial : toute médiation devient dangereuse si elle est utilisée pour forcer le pardon, nier la souffrance ou maintenir des rapports de domination. La médiation thérapeutique respecte le rythme des personnes et reconnaît le droit à la distance lorsque la proximité devient destructrice.

IV. RESTAURER LE DIALOGUE INTERGENERATIONNEL : REPARER LES FRACTURES DU TEMPS

L'un des effets les plus délétères des conflits spirituels familiaux est la **rupture du dialogue entre les générations**. Les aînés sont perçus comme des menaces, les jeunes comme des rebelles ou des traîtres aux traditions. La parole circule mal, chargée de peurs anciennes et de rancœurs accumulées.

Restaurer le dialogue intergénérationnel est un enjeu thérapeutique majeur. Il ne s'agit pas de revenir à une obéissance aveugle, ni d'imposer une modernité arrogante, mais de **reconstruire un espace de parole où chaque génération peut exister sans être disqualifiée.**

La MTHS observe que de nombreux conflits attribués à la sorcellerie masquent en réalité des **conflits de valeurs, de pouvoir et de reconnaissance**. Les aînés, fragilisés par la perte de leur autorité symbolique, expriment parfois leur souffrance sous des formes détournées. Les jeunes, en quête d'autonomie, interprètent toute résistance comme une agression invisible.

La parole thérapeutique intergénérationnelle commence par la reconnaissance mutuelle des blessures. Elle exige des aînés qu'ils acceptent de raconter leur histoire sans l'imposer, et des jeunes qu'ils apprennent à écouter sans se sentir immédiatement menacés. Ce processus est long, souvent fragile, mais profondément réparateur.

Cliniquement, lorsque le dialogue intergénérationnel se restaure, on observe une diminution significative des accusations spirituelles, une amélioration du climat émotionnel et une transmission plus apaisée des savoirs et des valeurs.

CONCLUSION

La parole comme responsabilité et comme soin

Parler sans accuser n'est ni un luxe intellectuel ni une posture morale. C'est une **nécessité clinique** dans des contextes où la parole peut tuer socialement, spirituellement et parfois physiquement. La MTHS propose une éthique exigeante de la communication, fondée sur la responsabilité, la lenteur et le respect de la complexité humaine.

La parole thérapeutique ne cherche pas à gagner, mais à réparer. Elle accepte l'incertitude, refuse la simplification et protège la dignité de chacun. Elle reconnaît que l'on peut nommer la souffrance sans désigner de coupable, poser des limites sans condamner, chercher la vérité sans détruire la relation.

Dans les familles marquées par les conflits spirituels, apprendre à parler sans accuser est souvent le premier pas vers une paix durable. Car, en définitive, **ce n'est pas le silence qui détruit les familles, mais la parole mal utilisée**. Et ce n'est pas la parole qui sauve, mais la parole devenue soin.

PARTIE- IV :

SOIGNER PLUTÔT QUE COMBATTRE

La MTHS comme voie de réhabilitation

CHAPITRE-10 :

LE SORCIER COMME PATIENT SPIRITUEL

INTRODUCTION

Renverser le regard pour sauver l'humain

Dans l'imaginaire collectif, la figure du sorcier est presque toujours associée à la peur, à la menace et à la destruction. Il est celui qu'il faut démasquer, neutraliser, expulser ou éliminer symboliquement. Rarement est-il perçu comme un sujet de soin. Cette représentation, profondément enracinée dans les sociétés africaines contemporaines, s'est renforcée sous l'effet conjugué de la radicalisation religieuse, de la judiciarisation du mal et de la médicalisation incomplète des souffrances invisibles.

La **Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS)** opère ici un renversement paradigmatique majeur : elle propose de considérer le sorcier non comme un ennemi à abattre, mais comme un **patient spirituel**, porteur d'un handicap spécifique, inscrit dans une histoire personnelle, familiale et transgénérationnelle complexe. Ce déplacement du regard ne nie pas la réalité de la nuisance, ni la souffrance des victimes ; il modifie la manière d'y répondre.

Soigner plutôt que combattre ne relève pas d'une naïveté spirituelle, mais d'une **lucidité clinique**. L'histoire de la médecine montre que les sociétés progressent lorsqu'elles cessent de persécuter ce qu'elles ne comprennent pas pour commencer à l'étudier, le diagnostiquer et le traiter. La MTHS s'inscrit dans cette tradition humanisante, en affirmant que la sorcellerie, loin d'être

uniquement une malveillance volontaire, est souvent l'expression d'une **pathologie de l'invisible**, enracinée dans la souffrance, la fragmentation identitaire et les traumatismes non résolus.

Ce chapitre explore cette révolution silencieuse en quatre temps : les raisons pour lesquelles la MTHS refuse la diabolisation, les fondements du diagnostic différentiel, la classification des niveaux de handicap spirituel, et enfin les indications thérapeutiques qui en découlent.

I. POURQUOI LA MTHS REFUSE LA DIABOLISATION : UNE EXIGENCE CLINIQUE ET ETHIQUE

La diabolisation du sorcier repose sur une vision binaire du monde : d'un côté le bien, de l'autre le mal ; d'un côté les victimes, de l'autre les bourreaux. Si cette lecture offre un soulagement émotionnel immédiat, elle s'avère cliniquement stérile et socialement destructrice. La MTHS en identifie les limites majeures.

D'un point de vue clinique, la diabolisation empêche toute compréhension fine des mécanismes à l'œuvre. En réduisant l'individu à une entité maléfique, elle interdit l'exploration de son histoire, de ses blessures, de ses conditionnements et de ses conflits internes. Or, aucune pathologie — qu'elle soit psychique, somatique ou spirituelle — ne peut être soignée sans une compréhension minimale de ses causes.

D'un point de vue thérapeutique, la diabolisation aggrave souvent la situation qu'elle prétend résoudre. Le sujet diabolisé,

rejeté et humilié, entre dans des mécanismes de défense extrêmes : déni, clivage, agressivité, repli ou identification renforcée au rôle qui lui est assigné. La stigmatisation produit ainsi une **auto-réalisation du mal**, phénomène bien documenté en psychologie sociale.

Sur le plan éthique, enfin, la diabolisation pose un problème majeur : elle justifie des violences symboliques, sociales et parfois physiques au nom du bien. La MTHS rappelle une vérité fondamentale : **aucune société ne guérit en sacrifiant ses membres les plus fragiles**. La sorcellerie, comprise comme handicap spirituel, révèle souvent des trajectoires marquées par l'abandon, la jalousie intériorisée, les initiations précoces, les violences subies ou la solitude affective.

Refuser la diabolisation ne signifie pas nier la responsabilité. Cela signifie distinguer la **responsabilité thérapeutique** de la **condamnation morale**. La MTHS ne cherche pas à excuser, mais à soigner ; non à absoudre, mais à transformer.

II. DIAGNOSTIC DIFFERENTIEL MTHS : DISCERNER SANS ACCUSER

L'un des apports majeurs de la MTHS réside dans l'élaboration d'un **diagnostic différentiel** rigoureux, destiné à éviter les confusions meurtrières entre sorcellerie, troubles psychiques, conflits relationnels et projections collectives. Dans de nombreuses familles, l'absence de discernement conduit à des accusations erronées, aux conséquences irréversibles.

Le diagnostic différentiel MTHS repose sur une observation longitudinale et multidimensionnelle. Il distingue notamment :

1. **Les troubles psychiques à expression spirituelle**, tels que les troubles dissociatifs, les psychoses, les états dépressifs sévères ou les troubles de la personnalité, souvent interprétés à tort comme des manifestations de sorcellerie active.
2. **Les conflits relationnels chroniques**, marqués par la rivalité, la jalousie, les luttes de pouvoir ou les frustrations économiques, qui génèrent des projections spirituelles sans fondement clinique réel.
3. **Les traumatismes transgénérationnels**, où des événements anciens non élaborés se rejouent symboliquement à travers un membre désigné comme porteur du mal.
4. **Les véritables handicaps spirituels**, caractérisés par une altération durable de la relation à l'autre, une instrumentalisation inconsciente des liens, et une répétition de schémas de nuisance, souvent sans intention consciente.

Ce diagnostic exige du temps, de la prudence et une posture éthique stricte. La MTHS insiste sur un principe cardinal : **aucun diagnostic de handicap spirituel ne peut être posé dans l'urgence émotionnelle ou sous pression communautaire**. Le discernement clinique s'oppose frontalement aux logiques d'accusation immédiate.

III. NIVEAUX DE HANDICAP SPIRITUEL : UNE CLINIQUE DE LA GRADATION

Contrairement aux discours qui présentent la sorcellerie comme un état uniforme et définitif, la MTHS propose une **classification graduée des niveaux de handicap spirituel**, permettant d'adapter la prise en charge thérapeutique.

Le premier niveau correspond aux **fragilités spirituelles latentes**. Il s'agit de personnes marquées par des blessures affectives, une jalousie non élaborée, des frustrations profondes, mais qui n'exercent pas de nuisance active. À ce stade, le travail thérapeutique est essentiellement préventif.

Le deuxième niveau concerne les **handicaps spirituels réactionnels**, où la nuisance apparaît dans des contextes de crise, de rivalité ou de stress intense. Les comportements sont intermittents, souvent suivis de culpabilité ou de confusion. Ces patients sont généralement accessibles au soin.

Le troisième niveau correspond aux **handicaps structurés**, caractérisés par des schémas répétitifs de prédation relationnelle, une difficulté à reconnaître l'altérité et une instrumentalisation chronique des liens. Le patient n'est pas nécessairement conscient de son impact, mais la nuisance est durable.

Enfin, le quatrième niveau concerne les **handicaps spirituels sévères**, souvent associés à des initiations forcées, des traumatismes graves ou des ruptures identitaires profondes. La

prise en charge est longue, complexe, et nécessite des dispositifs de protection renforcés pour l'entourage.

Cette gradation permet de sortir de la logique du tout ou rien et d'introduire une **médecine de la nuance**, indispensable à toute démarche thérapeutique sérieuse.

IV. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : SOIGNER L'INVISIBLE SANS DETRUIRE LE LIEN

Les indications thérapeutiques de la MTHS découlent directement de cette compréhension clinique. Soigner un handicap spirituel ne consiste jamais à extirper un mal par la violence, mais à **restaurer des capacités relationnelles altérées**.

Les interventions incluent notamment :

- un travail de reconnaissance et de narration de l'histoire personnelle,
- la restauration progressive de l'empathie,
- des rituels de réparation symbolique non violents,
- un accompagnement psychospirituel de longue durée,
- et, lorsque nécessaire, une distance thérapeutique temporaire.

La MTHS insiste sur un point fondamental : **le soin du patient spirituel ne doit jamais se faire au détriment de la sécurité des autres**. La protection de la famille et de la communauté reste prioritaire. Soigner ne signifie pas exposer, ni sacrifier les victimes sur l'autel de la réhabilitation.

CONCLUSION :

Réhabiliter sans naïveté, soigner sans renoncer à la justice

En proposant de considérer le sorcier comme un patient spirituel, la MTHS ouvre une voie radicalement nouvelle, à la fois exigeante et profondément humaine. Elle refuse la facilité de la diabolisation sans tomber dans l'angélisme. Elle affirme que la guérison collective passe par la capacité à reconnaître la souffrance là où l'on ne voyait que le mal.

Soigner plutôt que combattre n'est pas un slogan. C'est une **discipline clinique**, une éthique du soin, une vision de la paix fondée sur la transformation plutôt que sur l'élimination. En réhabilitant le sorcier comme sujet de soin, la MTHS contribue à briser les cycles de violence invisible qui ravagent les familles et les communautés depuis des générations.

Car, en définitive, **une société ne se guérit jamais en multipliant ses ennemis, mais en élargissant sa capacité à soigner l'humain, même lorsqu'il fait peur.**

CHAPITRE -11 :

PROTOCOLES CLINIQUES DE PRISE EN CHARGE

INTRODUCTION

De la théorie du soin à l'acte thérapeutique

Après avoir posé les fondements anthropologiques, éthiques et cliniques de la MTHS, une question décisive s'impose : *comment soigne-t-on concrètement un handicap spirituel sans produire de nouvelles violences ?* Car toute théorie du soin, aussi humaniste soit-elle, perd sa valeur si elle ne s'incarne pas dans des pratiques rigoureuses, sécurisées et évaluables.

Dans de nombreuses traditions, la prise en charge de la sorcellerie présumée s'est historiquement organisée autour de gestes spectaculaires, d'exorcismes violents, de mises en accusation publiques et de ruptures sociales irréversibles. Ces pratiques, loin de guérir, ont souvent laissé derrière elles des individus brisés, des familles fragmentées et des traumatismes transgénérationnels durables.

La **Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS)** propose une rupture méthodologique claire : elle inscrit la prise en charge dans des **protocoles cliniques structurés**, progressifs et protecteurs, comparables, dans leur logique, aux protocoles de soins utilisés en médecine somatique ou en psychiatrie moderne. Soigner l'invisible devient alors un acte

responsable, mesuré, inscrit dans le temps long, et jamais livré à l'arbitraire émotionnel ou religieux.

Ce chapitre explore ces protocoles en quatre temps successifs, suivant une chronologie thérapeutique précise : le désenvoûtement thérapeutique encadré, la délivrance progressive et sécurisée, l'accompagnement spirituel et psychologique, et enfin le rôle déterminant de la famille dans la guérison.

I. LE DESENVOUTEMENT THERAPEUTIQUE ENCADRE : DENOUEUR SANS VIOLENTER

Dans le langage courant, le terme *désenvoûtement* évoque souvent une intervention brutale, destinée à arracher une force hostile par des moyens coercitifs. La MTHS opère ici une redéfinition fondamentale. Le désenvoûtement thérapeutique n'est pas une extraction violente du mal, mais un **processus de dénouement progressif des liens pathologiques à l'invisible**.

Cliniquement, le désenvoûtement encadré vise à identifier et à désactiver les **mécanismes d'emprise**, qu'ils soient symboliques, relationnels ou spirituels. Il ne s'agit pas de combattre une entité extérieure, mais de restaurer l'autonomie psychique et spirituelle du patient. Cette approche s'appuie sur une compréhension fine des traumatismes, des conditionnements précoces et des initiations subies ou héritées.

Le caractère *encadré* du désenvoûtement est essentiel. Aucune intervention n'est entreprise sans une évaluation préalable

rigoureuse, intégrant l'état psychique du patient, son environnement familial, son histoire spirituelle et son niveau de vulnérabilité. Cette évaluation permet d'éviter les erreurs majeures observées dans les pratiques non contrôlées : dissociation aiguë, effondrement identitaire, aggravation des symptômes ou passage à l'acte.

Le désenvoûtement thérapeutique se déroule par étapes, souvent discrètes, parfois silencieuses. Il peut inclure des temps de retrait symbolique, de clarification identitaire, de renoncement conscient à certains pactes intérieurs, mais toujours dans le respect du rythme du patient. La MTHS insiste sur un principe cardinal : **on ne retire jamais à un sujet ce qui a structuré sa survie sans lui offrir des ressources alternatives.**

Ainsi conçu, le désenvoûtement cesse d'être un spectacle pour devenir un acte clinique profond, visant la restauration de la liberté intérieure.

II. LA DELIVRANCE PROGRESSIVE ET SECURISEE : SORTIR DE LA LOGIQUE DE RUPTURE

Dans de nombreux contextes religieux, la délivrance est conçue comme un événement ponctuel, spectaculaire, censé marquer une rupture radicale entre l'avant et l'après. Cette vision, bien que séduisante, se révèle souvent contre-thérapeutique lorsqu'elle est appliquée à des handicaps spirituels complexes.

La MTHS propose une conception radicalement différente : la **délivrance progressive et sécurisée**. Ici, la délivrance n'est pas

un instant, mais un **processus**, comparable à la rééducation après un traumatisme physique. Elle suppose des avancées, des rechutes possibles, des ajustements continus.

Progressive, la délivrance respecte la capacité du patient à intégrer le changement. Une transformation trop rapide peut provoquer une angoisse massive, une perte de repères ou une reconstruction défensive du symptôme. Sécurisée, elle s'inscrit dans un cadre protecteur, où les manifestations émotionnelles ou spirituelles sont contenues, interprétées et accompagnées.

La délivrance MTHS ne cherche pas à produire des signes visibles de victoire spirituelle. Elle se mesure à des critères cliniques concrets : diminution de la compulsion relationnelle, amélioration de l'empathie, capacité accrue à reconnaître l'autre comme sujet, réduction des comportements de nuisance, stabilisation émotionnelle.

Un point fondamental distingue cette approche des pratiques violentes : **la délivrance n'est jamais imposée**. Elle repose sur un consentement éclairé du patient, même lorsque celui-ci est ambivalent. La contrainte produit la résistance ; la progression accompagnée favorise l'intégration durable.

Ainsi, la délivrance cesse d'être une rupture brutale pour devenir un chemin de réhabilitation intérieure.

III. ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL ET PSYCHOLOGIQUE : SOIGNER LA PERSONNE ENTIERE

L'un des apports majeurs de la MTHS est l'intégration explicite de l'accompagnement spirituel et psychologique dans un même dispositif thérapeutique. Là où certaines approches opposent foi et psychologie, la MTHS les considère comme **complémentaires**, à condition que chacune respecte son champ et ses limites.

Sur le plan psychologique, l'accompagnement vise à travailler les blessures anciennes, les traumatismes non élaborés, les mécanismes de défense et les distorsions relationnelles. Il permet au patient de mettre des mots sur son histoire, de comprendre ses comportements et de reconstruire une identité moins fragmentée. Ce travail est essentiel pour éviter que le handicap spirituel ne se réinstalle sous une autre forme.

Sur le plan spirituel, l'accompagnement vise à restaurer une relation apaisée à l'invisible. Il ne s'agit pas d'imposer un système de croyances, mais d'aider le patient à sortir de la peur, de la culpabilité et de la toute-puissance imaginaire. Une spiritualité thérapeutique, dans la perspective MTHS, est une spiritualité qui **apaise, responsabilise et humanise**.

L'articulation entre ces deux dimensions nécessite une grande rigueur. Toute interprétation spirituelle doit être confrontée à la réalité psychique, et inversement. Cette vigilance évite les dérives

mystiques, les interprétations abusives et les régressions traumatiques.

L'accompagnement MTHS s'inscrit dans la durée. Il accepte la lenteur comme une vertu clinique, car la réparation profonde ne peut être précipitée sans risque.

IV. LE ROLE DE LA FAMILLE DANS LA GUERISON : DE LA SUSPICION A LA CO-THERAPIE

Aucun protocole de prise en charge ne peut réussir durablement sans prendre en compte la **famille**, car le handicap spirituel est rarement une pathologie isolée. Il s'inscrit dans un système relationnel, souvent chargé de tensions anciennes, de silences et de projections.

La MTHS considère la famille non comme un simple décor, mais comme un **acteur thérapeutique potentiel**. Toutefois, cette implication doit être soigneusement encadrée. Une famille livrée à ses peurs peut devenir un facteur aggravant ; une famille accompagnée peut devenir un puissant levier de guérison.

Le premier travail consiste à **désamorcer la logique accusatoire**. Tant que la famille cherche un coupable plutôt qu'une compréhension, aucun soin n'est possible. La MTHS aide les proches à passer d'une posture de surveillance à une posture de soutien critique, fondée sur des limites claires.

Ensuite, la famille est progressivement invitée à participer à la restauration du lien : modification des interactions, reconnaissance des responsabilités partagées, réparation symbolique de certaines injustices anciennes. Ce travail est souvent délicat, car il confronte chacun à sa propre part de vulnérabilité.

La famille joue également un rôle central dans la **prévention des rechutes**. Un environnement relationnel plus sain réduit considérablement le risque de réactivation du handicap spirituel. À l'inverse, un climat de suspicion permanente recrée les conditions de la pathologie.

Dans certains cas, la MTHS recommande une **distance thérapeutique temporaire**, lorsque la proximité familiale demeure trop toxique. Cette distance n'est pas un échec, mais une stratégie de protection et de soin.

CONCLUSION

Des protocoles pour réconcilier soin, sécurité et dignité

Les protocoles cliniques de la MTHS traduisent une conviction profonde : **on ne guérit pas l'invisible par la violence, mais par la rigueur, la patience et le respect de la dignité humaine**. Désenvoûter sans violenter, délivrer sans briser, accompagner sans dominer, impliquer la famille sans persécuter — telle est l'éthique exigeante de cette approche.

En inscrivant la prise en charge du handicap spirituel dans des protocoles structurés, la MTHS contribue à sortir la question de la sorcellerie du registre de la peur et de l'arbitraire. Elle propose une médecine de l'invisible qui soigne sans nier la réalité du mal, mais refuse d'y répondre par des pratiques qui détruisent l'humain.

Soigner plutôt que combattre devient alors plus qu'un principe : une **discipline clinique**, une sagesse appliquée, capable de transformer durablement les individus, les familles et les communautés.

CHAPITRE-12 :

REINTEGRER SANS NAÏVETE

Entre prudence clinique et espérance lucide

INTRODUCTION

Le retour comme zone de haute vulnérabilité

La guérison spirituelle ne se mesure pas à l'extinction spectaculaire d'un symptôme, mais à la capacité retrouvée d'un sujet à **habiter le lien sans le contaminer**. Dans les trajectoires de réhabilitation suivies par la MTHS, le moment du retour – retour dans la famille, dans le clan, dans la communauté – constitue une **zone critique**, parfois plus dangereuse que la phase aiguë du trouble. Là où le combat a cessé, là où le soin a porté ses fruits, s'ouvre un espace paradoxal : celui de la **réintégration**, fragile, instable, profondément exposée aux rechutes.

Réintégrer n'est jamais un simple retour à l'état antérieur. Toute pathologie spirituelle laisse une trace. Toute traversée thérapeutique modifie la structure interne du sujet et celle du groupe qui l'accueille. La MTHS s'oppose donc radicalement à toute vision naïve de la guérison comme restauration intégrale du passé. Elle propose une autre voie : **réintégrer sans illusion**, avec lucidité, prudence, accompagnement et responsabilité partagée.

I. PROCESSUS DE REHABILITATION SOCIALE

1. De l'isolement thérapeutique à la présence graduée

La première erreur des systèmes traditionnels non encadrés est de croire que la guérison autorise une réintégration immédiate et totale. Or, du point de vue clinique, le sujet ayant présenté un trouble spirituel profond demeure longtemps **en phase de vulnérabilité adaptative**. Ses mécanismes de défense sont encore fragiles, ses anciennes stratégies relationnelles peuvent ressurgir, et ses capacités de régulation émotionnelle restent instables.

La MTHS conçoit donc la réhabilitation sociale comme un **processus graduel**, structuré en étapes, chacune évaluée selon des critères précis : stabilité émotionnelle, cohérence du discours, capacité à reconnaître ses limites, absence de comportements d'emprise ou de manipulation symbolique. Le retour n'est pas un événement, mais une **trajectoire**.

Dans un premier temps, la présence du sujet est limitée, ritualisée, encadrée. Il réapprend à être là sans occuper tout l'espace, à parler sans dominer, à exister sans se nourrir du déséquilibre d'autrui. Cette phase est essentielle : elle permet au groupe d'observer sans juger, et au patient de se réapproprier une place non toxique.

2. Redéfinition du statut symbolique

Dans de nombreuses cultures, le sujet soupçonné ou reconnu comme sorcier occupait auparavant une place paradoxale :

à la fois craint, consulté, marginalisé et central. La guérison impose une **déconstruction de ce statut symbolique**. Réintégrer sans naïveté, c'est accepter que le sujet ne retrouve ni son ancien pouvoir ni sa position antérieure.

La MTHS insiste sur un principe fondamental : **aucune guérison n'autorise le retour à une position de pouvoir spirituel**. Le patient réhabilité ne devient ni guide, ni médiateur, ni référent rituel. Il redevient un membre ordinaire du groupe, avec des droits, mais aussi des limites clairement établies. Cette redéfinition protège autant le sujet que la communauté, en évitant les projections dangereuses et les attentes irréalistes.

II. SURVEILLANCE BIENVEILLANTE

1. La vigilance comme acte de soin collectif

Le mot « surveillance » suscite souvent des résistances, tant il évoque le contrôle, la suspicion ou la répression. La MTHS propose une autre lecture : la **surveillance bienveillante** n'est pas une défiance, mais une extension du soin. Elle repose sur l'idée que la guérison spirituelle est un processus long, non linéaire, susceptible de fluctuations.

Surveiller, dans ce cadre, signifie **observer les signaux faibles** : modifications du langage, retrait progressif, regain d'influence informelle, retour de pratiques anciennes sous des formes atténuées. Cette vigilance n'est jamais solitaire ; elle est partagée entre plusieurs membres de la famille ou de la

communauté, afin d'éviter les interprétations subjectives ou les persécutions déguisées.

2. Cadres et repères explicites

La surveillance bienveillante ne peut exister sans règles claires. Dès la réintégration, des **repères explicites** sont posés : ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas, ce qui doit être signalé, ce qui relève de la vie privée. Le patient est informé de ces règles, non comme d'un soupçon permanent, mais comme d'un **dispositif de sécurité partagé**.

Cette transparence est essentielle. Elle empêche la confusion, désamorce les fantasmes de persécution et instaure un climat de responsabilité mutuelle. Le sujet sait qu'il est observé, mais aussi soutenu. Le groupe sait qu'il veille, mais sans traquer. C'est dans cet équilibre délicat que la confiance peut progressivement se reconstruire.

III. RECONSTRUCTION DES LIENS FAMILIAUX

1. Réparer sans effacer

Les familles ayant traversé une crise spirituelle profonde portent des blessures durables : trahisons symboliques, peurs silencieuses, culpabilités croisées. La reconstruction des liens ne peut donc pas reposer sur l'oubli ou le déni. La MTHS refuse les injonctions au pardon prématuré, qui ne font que déplacer la violence dans le non-dit.

Reconstruire, c'est d'abord **nommer ce qui a été vécu**, dans un cadre sécurisé, accompagné, parfois médiatisé par un thérapeute spirituel ou un ancien reconnu pour sa sagesse. La parole circule, non pour accuser, mais pour rendre intelligible. Chacun retrouve le droit de dire sa peur, sa colère, sa tristesse, sans que cela soit interprété comme une attaque.

2. Redéployer la confiance par des actes

La confiance ne se décrète pas ; elle se **reconstruit par des actes répétitifs, cohérents et modestes**. Le patient réhabilité est invité à poser des gestes simples, concrets, visibles : participation aux tâches communes, respect des engagements, capacité à demander de l'aide. Ces actes, plus que les discours, deviennent les fondations d'un lien renouvelé. Progressivement, les interactions cessent d'être chargées de suspicion. Les silences se peuplent autrement. Les regards se détendent. La famille ne redevient pas ce qu'elle était, mais elle devient autre chose : un espace plus conscient, parfois plus fragile, mais aussi plus lucide.

IV. Prévenir les rechutes spirituelles

1. Comprendre la rechute comme signal, non comme échec

Dans la perspective MTHS, la rechute n'est jamais interprétée comme une faute morale ou un retour au mal. Elle est envisagée comme un **signal clinique**, indiquant une surcharge émotionnelle, une fragilité relationnelle ou une exposition excessive à des facteurs déclenchants. Cette lecture non culpabilisante est essentielle pour intervenir rapidement et efficacement.

Prévenir les rechutes suppose donc un **suivi à long terme**, fait de rendez-vous réguliers, de bilans spirituels, d'espaces de parole. Le sujet apprend à reconnaître ses propres signaux d'alerte : fatigue intense, isolement, fascination renouvelée pour le secret ou le pouvoir. Cette auto-observation est l'un des marqueurs les plus fiables d'une guérison durable.

2. Maintenir un environnement protecteur

Enfin, la prévention des rechutes repose sur la capacité du groupe à maintenir un **environnement spirituellement sain**. Cela implique de limiter les pratiques à risque, de refuser les sollicitations ambiguës, de préserver des temps de repos et de silence. La guérison d'un individu ne peut être durable dans un milieu pathogène.

La MTHS insiste sur cette responsabilité collective : **soigner un sujet sans transformer son environnement revient à préparer la rechute**. La réintégration sans naïveté est donc un engagement partagé, une vigilance douce mais constante, une alliance entre science, sagesse et humanité.

CONCLUSION

La lucidité comme forme supérieure de compassion

Réintégrer sans naïveté, ce n'est pas refuser l'espérance. C'est lui donner une forme adulte, incarnée, responsable. La MTHS propose une vision exigeante mais profondément humaine de la guérison : une guérison qui n'efface pas le passé, mais qui apprend à vivre avec lui sans qu'il détruise l'avenir.

Dans cette approche, la lucidité n'est pas une dureté, mais une **forme supérieure de compassion**. Elle protège sans exclure, elle accueille sans s'aveugler, elle accompagne sans dominer. Et c'est peut-être là, dans cet équilibre fragile mais fertile, que se joue la véritable paix spirituelle.

PARTIE-V :
PRÉSERVER LA PAIX SUR LE LONG TERME
Prévention et responsabilité collective

CHAPITRE -13 :

ÉDUCUER LES ENFANTS A L'EQUILIBRE SPIRITUEL

INTRODUCTION

Semer avant la tempête

Dans toute société, l'éducation spirituelle des enfants représente une zone de vulnérabilité extrême, mais aussi l'occasion la plus féconde de prévention. Les traumatismes spirituels se transmettent souvent de manière silencieuse, à travers des peurs, des malentendus, ou des pratiques ritualisées mal encadrées. Une croyance transmise dans la peur devient une chaîne invisible qui pèse sur les générations suivantes. À l'inverse, une éducation équilibrée peut constituer un **bouclier durable**, une protection intérieure qui favorise la résilience, l'empathie et la cohésion familiale.

La MTHS considère l'éducation spirituelle des enfants non pas comme une simple initiation religieuse, mais comme une **construction méthodique de l'équilibre intérieur**. Elle articule trois dimensions : la transmission saine des croyances, la protection contre la peur, et le développement d'une spiritualité éducative et non traumatisante. Ces axes, bien combinés, permettent de préparer l'enfant à affronter le monde invisible sans crainte paralysante, tout en cultivant le respect de l'altérité et la responsabilité collective.

I. TRANSMISSION SAINTE DES CROYANCES

1. De la croyance à la compréhension

La première étape consiste à distinguer **la croyance vécue** de **la croyance comprise**. Trop souvent, les enfants absorbent des récits spirituels comme des instructions absolues, sans qu'ils puissent en saisir le sens ni le contexte. Cela crée une anxiété diffuse et installe des rapports de domination symbolique dès le plus jeune âge.

La MTHS recommande une approche **explicative et dialogique**. Chaque croyance est transmise avec une explication de son origine, de sa fonction, et de ses limites. L'enfant apprend ainsi à **penser avec la croyance** plutôt qu'à la subir aveuglément. Par exemple, un récit sur la sorcellerie n'est pas présenté comme une menace imminente, mais comme une métaphore des dangers liés à la malveillance ou à l'incompréhension des autres.

Cette pédagogie favorise l'émergence d'un **discernement précoce** : l'enfant est capable de distinguer ce qui relève de la réalité observable de ce qui appartient au symbolique, ce qui constitue un pilier essentiel pour prévenir les **handicaps spirituels futurs**.

2. Les rituels comme espaces d'apprentissage

Les rituels familiaux et communautaires, lorsqu'ils sont employés dans un cadre sécurisant, deviennent des outils pédagogiques puissants. Dans la perspective MTHS, **la répétition**

codifiée des rituels permet à l'enfant de se familiariser avec le langage symbolique de la spiritualité, d'apprendre la responsabilité collective et d'expérimenter la régulation émotionnelle.

Cependant, ces rituels doivent être **libres de coercition et de peur**. Ils ne servent pas à effrayer, à punir ou à instiller la suspicion, mais à créer des repères sécurisants. Par exemple, la participation à un rituel de gratitude ou de purification symbolique renforce la conscience de la responsabilité personnelle et communautaire, sans jamais présenter un danger moral ou physique.

II. PROTECTION DES ENFANTS CONTRE LA PEUR

1. Identifier les vecteurs de peur

La peur est l'élément central dans la transmission intergénérationnelle des traumatismes spirituels. Elle se manifeste souvent à travers des menaces implicites (« si tu fais cela, le sorcier viendra ») ou explicites (« cette maison est maudite »). La MTHS souligne que **la peur non médiatisée est toxique**, car elle stimule les circuits neuronaux de stress chronique, altère le développement émotionnel et peut installer des comportements anxieux persistants.

Identifier ces vecteurs de peur nécessite une observation attentive de l'enfant et de son environnement : récits exagérés, attitudes intimidantes, croyances mal expliquées, langage parental anxiogène. La vigilance bienveillante des adultes devient alors un acte thérapeutique préventif.

2. Techniques de neutralisation de la peur

La neutralisation de la peur repose sur trois stratégies complémentaires :

1. **L'information adaptée à l'âge** : expliquer ce qui est réel et ce qui relève du symbolique, de manière progressive et compréhensible.
2. **La verbalisation des émotions** : encourager l'enfant à exprimer sa peur, à la nommer, à la raconter, afin qu'elle perde son intensité paralysante.
3. **La substitution par des expériences sécurisantes** : remplacer les menaces par des rituels positifs, des histoires d'héroïsme moral ou des pratiques de protection symbolique qui responsabilisent sans effrayer.

Cette approche transforme la peur en **outil d'apprentissage** plutôt qu'en facteur de risque. L'enfant apprend à reconnaître les dangers réels, à gérer l'incertitude et à développer son autonomie émotionnelle et spirituelle.

III. SPIRITUALITE EDUCATIVE ET NON TRAUMATISANTE

1. La spiritualité comme éducation au discernement

La MTHS prône une **spiritualité éducative**, qui ne s'appuie ni sur la menace ni sur la coercition, mais sur la compréhension et l'expérimentation encadrée. Chaque pratique spirituelle devient une leçon sur la vie : la patience, le respect des autres, l'empathie, la capacité à gérer les émotions difficiles.

Dans ce cadre, l'enfant apprend à :

- distinguer le bien du mal sans se sentir responsable de forces invisibles qu'il ne contrôle pas ;
- identifier les signes symboliques sans les confondre avec des réalités physiques ;
- développer un langage intérieur capable de canaliser l'énergie émotionnelle et spirituelle.

Ainsi, la spiritualité cesse d'être un **fardeau anxiogène** pour devenir une **ressource intérieure**. L'enfant ne redoute plus le monde invisible, mais apprend à coexister avec lui de manière responsable.

2. Prévention des traumatismes spirituels

Une spiritualité traumatisante est celle qui utilise la peur comme moteur éducatif. Dans de nombreuses traditions, cette méthode est restée dominante : menaces de malédiction, rituels coercitifs, châtiments symboliques. La MTHS propose une alternative radicale : **toute pratique spirituelle avec un enfant doit être évaluée selon son impact psychologique**, mesurable par la sérénité observée, la confiance en soi et la sécurité perçue.

Cette approche repose sur des principes clairs :

- **Respect de l'intégrité émotionnelle** : aucune peur ne doit être induite pour produire un comportement ou un apprentissage.
- **Accompagnement graduel** : l'exposition aux symboles, rituels ou récits se fait par étapes, adaptées à l'âge et à la maturité cognitive.

- **Supervision familiale et communautaire** : l'enfant n'est jamais seul face à l'invisible. La présence adulte sécurisante est constitutive du protocole éducatif.

Par cette méthode, la prévention des traumatismes spirituels devient un **acte de responsabilité collective**, non seulement pour la famille immédiate, mais aussi pour l'école, les communautés religieuses et les pairs.

IV. IMPLICATIONS POUR LA PREVENTION A LONG TERME

Éduquer les enfants à l'équilibre spirituel a des conséquences systémiques. Chaque génération ainsi formée réduit le risque de **handicaps spirituels transgénérationnels** et contribue à **préserver la paix familiale et communautaire**. La prévention devient alors un investissement stratégique : prévenir les traumatismes précoces, c'est éviter les conflits futurs, les ruptures relationnelles et la propagation de peurs paralysantes.

La MTHS recommande un suivi longitudinal : observation régulière, ajustement des pratiques éducatives, discussions intergénérationnelles, rituels de consolidation symbolique et espaces de parole ouverts. L'objectif n'est pas de produire une conformité religieuse, mais une **maturité spirituelle sécurisante**, où la croyance est comprise, l'émotion régulée et le lien social renforcé.

CONCLUSION

Semer la résilience et la paix

Éduquer les enfants à l'équilibre spirituel n'est pas une simple transmission doctrinale. C'est un **processus clinique, éthique et pédagogique**, qui conjugue prévention, discernement et sécurité affective. La MTHS nous enseigne que les traumatismes spirituels sont évitables si les adultes apprennent à transformer la peur en compréhension, la croyance en dialogue et la pratique en expérience sécurisante.

Ainsi se dessine une société capable de **préserver la paix sur le long terme** : une société où les enfants grandissent avec la liberté intérieure de distinguer le bien du mal, de coexister avec l'invisible sans angoisse, et de contribuer à la responsabilité collective. L'éducation spirituelle devient un vecteur de **prévention durable**, un investissement dans la sérénité des générations futures et un pilier essentiel de la reconstruction familiale et communautaire.

CHAPITRE-14 : **FAMILLE, TRADITION ET FOI : TROUVER L'EQUILIBRE**

INTRODUCTION

La convergence nécessaire des savoirs

Au cœur de toute communauté, la famille constitue le microcosme où se cristallisent les tensions et les harmonies des croyances, des pratiques et des valeurs. La vie spirituelle des individus, et particulièrement celle des plus vulnérables, se déploie dans ce tissu complexe, tissé de **savoirs traditionnels ancestraux**, de **foi chrétienne** et de régulations sociales quotidiennes. La question qui se pose, avec acuité et délicatesse, est celle de l'équilibre : **comment articuler ces univers de sens sans détruire ni fragiliser la cohésion familiale, sans imposer la peur ni la domination ?**

Dans le cadre de la MTHS, ce chapitre se propose d'analyser trois dimensions complémentaires : la réconciliation des savoirs traditionnels et chrétiens, les limites éthiques inhérentes à chaque approche, et la construction d'un cadre responsable d'intervention. Ensemble, elles constituent le socle d'une pratique clinique et éducative capable de préserver la paix sur le long terme.

I. RECONCILIATION DES SAVOIRS TRADITIONNELS ET CHRETIENS

1. Une coexistence possible mais exigeante

L'histoire des sociétés africaines montre que les croyances traditionnelles et la foi chrétienne coexistent depuis plusieurs siècles, parfois dans une harmonie fragile, parfois dans un conflit latent. Les pratiques rituelles ancestrales, les conceptions de l'invisible et la médiation spirituelle par les aînés entretiennent un rapport avec le sacré très différent de celui proposé par le christianisme, centré sur la révélation biblique, le pardon et la grâce divine.

Pour la MTHS, la **coexistence n'est pas seulement possible : elle est souhaitable**, dès lors qu'elle se fonde sur le respect mutuel, la transparence et la lucidité. L'objectif n'est pas de fusionner les croyances, mais de **créer un dialogue interdisciplinaire** où chaque savoir conserve sa légitimité et son rôle, tout en acceptant des limites claires pour protéger les enfants et les adultes vulnérables.

2. Méthodes de réconciliation dans la famille

La réconciliation s'opère à plusieurs niveaux :

- **Le niveau éducatif** : expliquer aux enfants les différences entre traditions et foi chrétienne, montrer la complémentarité possible, et éviter toute transmission de peur ou de menace. Par exemple, un conte ancestral sur la sorcellerie peut être

présenté comme une leçon morale, tandis que l'enseignement chrétien souligne la responsabilité personnelle et l'amour du prochain.

- **Le niveau ritualisé** : certains rituels traditionnels peuvent être conservés à condition qu'ils ne compromettent pas les valeurs chrétiennes ni la sécurité psychologique des participants. La MTHS recommande d'observer ces pratiques, de les analyser, puis d'autoriser uniquement celles qui favorisent la cohésion et le bien-être.
- **Le niveau symbolique et narratif** : permettre aux membres de la famille de raconter et d'interpréter des expériences spirituelles passées sous un angle compréhensible et sécurisant, en valorisant la diversité des perspectives plutôt que la conformité.

Cette réconciliation est exigeante : elle demande des adultes conscients, capables de **métacognition culturelle et spirituelle**, capables de négocier des espaces symboliques communs sans imposer leur autorité par la peur ou l'arbitraire.

II. LIMITES ETHIQUES DE CHAQUE APPROCHE

1. Limites des savoirs traditionnels

Les pratiques traditionnelles comportent des bénéfices incontestables : elles créent des repères symboliques, renforcent le lien communautaire, et proposent des stratégies de résolution de conflits invisibles. Cependant, elles présentent aussi des risques éthiques :

- **Instrumentalisation de la peur** : menaces implicites ou explicites, stigmatisation des individus, transmission de la culpabilité.
- **Pouvoirs symboliques disproportionnés** : certains aînés ou praticiens peuvent exercer une autorité excessive, qui limite l'autonomie des individus.
- **Transmission de stéréotypes générationnels** : le regard sur les enfants, les femmes, ou les « sorciers présumés » peut reproduire des pratiques discriminatoires.

La MTHS recommande une vigilance permanente : chaque pratique traditionnelle doit être évaluée selon son impact sur le psychisme et la sécurité de la famille, et modulée pour prévenir tout traumatisme.

2. Limites de l'approche chrétienne

La foi chrétienne, lorsqu'elle est comprise comme pure doctrine ou exercice ritualiste, peut également générer des effets indésirables :

- **Diabolisation excessive** : interpréter chaque conflit ou chaque trouble comme l'œuvre d'une entité maléfique peut renforcer la peur et l'angoisse.
- **Rigidité dogmatique** : imposer des croyances sans dialogue peut marginaliser des membres de la famille ou étouffer le discernement critique.

- **Exclusion des savoirs traditionnels** : nier l'histoire et la culture des ancêtres peut créer un sentiment d'inadéquation identitaire chez les enfants et adolescents.

Ainsi, la MTHS prône une lecture **contextualisée et critique** de la foi chrétienne : respecter ses principes sans négliger la dimension humaine, psychologique et symbolique des pratiques traditionnelles.

III. CADRE RESPONSABLE D'INTERVENTION

1. Principes de sécurité et de prudence

La réconciliation des savoirs et la coexistence pacifique des pratiques exigent un cadre clair. La MTHS propose les **principes fondamentaux** suivants :

- **Consentement et explicitation** : tout rituel ou pratique doit être expliqué et accepté par les participants.
- **Supervision adulte** : les interventions impliquant des enfants ou des membres vulnérables doivent être encadrées par des adultes responsables et formés à la détection des risques émotionnels ou psychiques.
- **Gradualité** : toute exposition aux croyances ou rituels se fait progressivement, avec observation attentive des réactions émotionnelles et psychologiques.

Ces principes ne sont pas seulement protecteurs : ils sont pédagogiques. Ils enseignent à la famille à **gérer le sacré avec discernement**, à respecter les limites de chacun, et à prévenir l'émergence de conflits invisibles ou de traumatismes.

2. Méthodologie d'intervention

L'application pratique du cadre responsable se déroule selon plusieurs étapes :

1. **Évaluation initiale** : analyser les croyances dominantes, identifier les zones de conflit potentiel, observer les dynamiques familiales.
2. **Cartographie des pratiques** : recenser les rituels et comportements spirituels, évaluer leur impact sur les enfants, les adolescents et les adultes vulnérables.
3. **Dialogue structuré** : organiser des temps de discussion où chaque membre peut exprimer ses attentes et ses limites, avec médiation si nécessaire.
4. **Supervision continue** : maintenir un suivi régulier pour observer la réintégration des pratiques, prévenir les abus, et renforcer les comportements sécurisants.

Cette méthodologie transforme l'intervention spirituelle en **pratique clinique responsable**, où l'équilibre entre tradition et foi devient un objectif mesurable et évolutif.

3. Rôle de la famille et de la communauté

L'interaction entre famille et communauté constitue la clef de la durabilité. La famille est le premier lieu de régulation, mais la communauté offre un soutien symbolique et normatif : transmission de valeurs, surveillance bienveillante, validation des rituels sécurisés. La MTHS considère que **la responsabilité collective**

est indissociable de la prévention à long terme. La paix spirituelle ne peut être préservée par un seul individu ; elle exige un engagement partagé, lucide et éthique.

IV. VERS UN EQUILIBRE DURABLE

L'équilibre entre famille, tradition et foi n'est ni naturel ni acquis. Il se construit par une **observation attentive, un dialogue continu et une vigilance bienveillante**. Il suppose la capacité des adultes à reconnaître les limites de leurs savoirs, à accepter le doute et à intégrer la dimension psychologique et symbolique de chaque pratique.

La MTHS montre que cet équilibre est possible lorsqu'on adopte une posture de **responsabilité critique** :

- respecter la légitimité des savoirs traditionnels tout en limitant leurs excès ;
- pratiquer la foi chrétienne avec profondeur et discernement sans diaboliser ni effrayer ;
- structurer l'intervention dans un cadre sécurisant, éthique et supervisé ;
- considérer chaque membre, et particulièrement les enfants, comme acteur de sa protection et de son éducation spirituelle.

Ce cheminement crée une famille capable de **résilience, de dialogue intergénérationnel et de prévention des traumatismes spirituels**, fondement indispensable d'une paix durable et d'une cohésion sociale renforcée.

CONCLUSION

La famille comme espace de sagesse et de protection

Réconcilier famille, tradition et foi n'est pas un luxe théorique : c'est une **nécessité clinique et sociale**. La MTHS nous rappelle que chaque croyance, chaque rituel et chaque parole porte un potentiel de soin ou de blessure. L'équilibre se conquiert, pas se présume ; il se cultive, avec prudence, patience et humilité.

En intégrant la réflexion sur les limites éthiques, la méthodologie responsable et la supervision collective, la famille devient un **espace de sagesse** : capable de protéger les plus vulnérables, d'éduquer à la sécurité spirituelle, et d'assurer que les pratiques religieuses et traditionnelles nourrissent l'amour, la confiance et la paix plutôt que la peur et la fragmentation.

Ainsi, dans ce chapitre final de la PARTIE V, se dessine l'idée cardinale de la MTHS : **préserver la paix sur le long terme n'est pas l'affaire d'une seule croyance ou d'un seul savoir, mais le fruit d'un dialogue responsable, d'une vigilance collective et d'une éducation éclairée au discernement spirituel.**

CHAPITRE-15 :

VERS UNE CULTURE DE PAIX SPIRITUELLE

INTRODUCTION

Dépasser la peur et la logique punitive

Dans les sociétés où le mystère de l'invisible s'entrelace avec la vie quotidienne, la peur du sorcier a longtemps structuré les comportements collectifs. Elle a généré des pratiques de suspicion, des chasses aux présumés coupables et des traumatismes récurrents, souvent transmis de génération en génération. La violence symbolique, parfois réelle, n'a fait qu'accentuer les fractures familiales et communautaires, créant un cercle vicieux de suspicion et de stigmatisation.

La MTHS propose un changement de paradigme radical : **passer de la peur et de la répression à la prévention, au soin et à la réconciliation**. Ce chapitre explore comment sortir de la logique de chasse aux sorciers, assumer la responsabilité communautaire et faire de la famille le lieu privilégié de la guérison collective. L'objectif n'est pas de nier l'existence de pratiques spirituelles potentiellement néfastes, mais de **réformer les mécanismes sociaux et éducatifs** afin de prévenir les conflits et de construire un environnement propice à la paix durable.

I. SORTIR DE LA LOGIQUE DE CHASSE AUX SORCIERS

1. La genèse de la peur punitive

Historiquement, la peur du sorcier a servi à **réguler les comportements**, à expliquer l'inexplicable et à maintenir une cohésion sociale par la sanction symbolique. Toutefois, cette logique a souvent échoué : en criminalisant l'invisible et en stigmatisant les individus, elle a produit davantage de traumatismes que de protection. Les enfants, les adolescents et même les adultes vulnérables ont été exposés à une double violence : celle de la croyance imposée et celle des sanctions communautaires.

La MTHS démontre que **la peur engendre la peur**. Elle inhibe le discernement, accroît la suspicion, et transforme chaque événement malheureux en accusation potentielle. Les familles fragmentées par ces logiques vivent dans un climat permanent d'angoisse, où la transmission intergénérationnelle de la peur devient un facteur majeur de handicap spirituel.

2. Transition vers la prévention et le soin

Sortir de la logique punitive ne signifie pas ignorer le danger ou minimiser les comportements à risque. La MTHS propose un **renversement méthodologique** : chaque situation perçue comme potentiellement « sorcière » est d'abord analysée selon un **diagnostic différentiel spirituel et psychosocial**, puis abordée par des stratégies de prévention et de soin, plutôt que par la répression.

Cette approche repose sur trois principes :

- **Neutralité clinique** : observer sans diaboliser, comprendre sans juger.
- **Accompagnement progressif** : intervenir selon les besoins réels, en priorisant la sécurité psychologique et la stabilité familiale.
- **Éducation à la vigilance constructive** : transformer l'angoisse en outils de prévention et de discernement, plutôt qu'en soupçons permanents.

Ainsi, la chasse aux sorciers se transforme en **culture de discernement et de prévention**, où chaque membre de la communauté devient un acteur responsable de la sécurité collective, sans recourir à la violence ni à la stigmatisation.

II. RESPONSABILITE COMMUNAUTAIRE

1. La communauté comme acteur de paix

Dans la perspective MTHS, la famille ne peut préserver la paix seule. La communauté – qu'elle soit villageoise, religieuse ou culturelle – joue un rôle central : elle fixe les normes, accompagne la transmission des croyances et assure un suivi collectif. Une communauté responsable ne se contente pas de punir ou d'exclure ; elle **veille, conseille et soutient**.

Ce rôle implique :

- la **formation des leaders spirituels et traditionnels** à une approche éthique et sécurisante ;
- la **supervision collective des rituels** afin d'éviter les abus symboliques ou émotionnels ;
- la **création d'espaces de dialogue intergénérationnel** pour que la parole circule librement, réduisant ainsi les malentendus et les suspicions.

2. Surveillance bienveillante et prévention

La MTHS encourage une **vigilance partagée** : chaque adulte responsable observe les signaux de fragilité spirituelle, émotionnelle ou comportementale sans stigmatiser. La surveillance bienveillante est proactive : elle anticipe les conflits et instaure des mesures de protection avant que la peur ne se transforme en accusation.

Cette responsabilité communautaire repose sur trois leviers :

1. **Observation systématique des signes de détresse** chez les enfants, adolescents et adultes vulnérables ;
2. **Encadrement éthique des pratiques rituelles et religieuses** ;
3. **Transmission de savoirs sécurisants** qui enseignent la prudence sans la peur, la vigilance sans la suspicion.

Ainsi, la communauté devient un **filet protecteur**, capable de prévenir les traumatismes collectifs et de favoriser la cohésion sociale, tout en respectant la diversité des croyances.

III. LA FAMILLE COMME LIEU DE GUERISON COLLECTIVE

1. La famille comme microcosme thérapeutique

Si la communauté assure la prévention, la famille constitue le lieu privilégié de **réintégration et de guérison**. La MTHS définit la famille comme un **microcosme où se négocient le lien, la sécurité et la régulation émotionnelle**. Les traumatismes spirituels peuvent y être identifiés précocement et traités à travers :

- des rituels encadrés de purification symbolique ;
- la parole et le dialogue intergénérationnel ;
- des pratiques quotidiennes favorisant la confiance, l'attention et la responsabilité mutuelle.

Dans ce cadre, chaque membre devient **acteur et témoin** de la guérison, participant activement à la consolidation des liens et à la prévention des rechutes.

2. Stratégies concrètes de guérison familiale

La guérison collective repose sur trois axes :

1. **Communication sécurisante** : instaurer des temps de parole où chaque membre peut exprimer ses craintes, ses expériences ou ses doutes, sans crainte de jugement ou de sanction.
2. **Pratiques symboliques positives** : remplacer les rituels de peur par des gestes collectifs de gratitude, de protection et de cohésion.
3. **Encadrement de la réintégration des individus vulnérables** : les membres guéris ou en réhabilitation reprennent progressivement leurs interactions avec le

groupe, sous supervision, afin de renforcer la sécurité affective et spirituelle.

Ces stratégies permettent de **réparer les fractures anciennes**, de restaurer la confiance et d'installer une culture durable de paix dans la cellule familiale.

IV. CONSTRUIRE UNE CULTURE DE PAIX SPIRITUELLE

1. La paix comme apprentissage

La paix spirituelle n'est pas innée. Elle se construit par la pratique répétée de comportements responsables, par le dialogue ouvert et par la régulation collective des émotions et des croyances. Dans cette perspective, chaque individu, famille et communauté devient **enseignant et apprenant**, apprenant à coexister avec l'invisible, à anticiper les conflits et à prévenir les traumatismes.

2. Intégration des pratiques éducatives et thérapeutiques

Pour instaurer une culture de paix, la MTHS recommande une **intégration systématique des pratiques éducatives, thérapeutiques et communautaires** :

- les enfants sont éduqués à la vigilance et au discernement ;
- les familles sont formées à la communication sécurisante et à la supervision bienveillante ;
- les communautés assurent la formation des leaders et la supervision éthique des rituels.

Cette intégration favorise une **responsabilité partagée**, où la prévention, la protection et la guérison ne dépendent plus de la peur ou de l'autorité punitive, mais de la conscience collective et de la coopération proactive.

CONCLUSION

Une société capable de paix spirituelle

Vers une culture de paix spirituelle, chaque maillon de la société trouve sa place :

- l'**individu**, capable de discernement et de maîtrise de ses émotions ;
- la **famille**, microcosme de guérison et de prévention ;
- la **communauté**, garante de normes éthiques et de supervision bienveillante.

En abandonnant la logique de chasse aux sorciers, en assumant la responsabilité collective et en consolidant la famille comme lieu de guérison, la société construit un espace où la peur cède la place à la confiance, où le soin remplace la punition, et où l'équilibre spirituel devient une pratique quotidienne partagée.

La MTHS démontre ainsi que **la paix spirituelle n'est pas un idéal inaccessible, mais un projet concret et réalisable**, fondé sur la prévention, l'éducation, la responsabilité et la guérison collective. Ce projet invite chaque génération à devenir **actrice et gardienne de la sérénité**, semant durablement une culture de paix qui traverse le temps et les croyances.

CONCLUSION GÉNÉRALE

L'EPREUVE DU VIVRE-ENSEMBLE

Depuis les premières pages de ce livre, nous avons exploré les dynamiques complexes qui structurent les relations humaines lorsque le monde visible et le monde invisible s'entrelacent. Nous avons observé comment la peur, la suspicion et les traumatismes spirituels peuvent fissurer les familles, fragiliser les communautés et altérer la confiance intergénérationnelle.

Au fil de nos analyses, un fil rouge s'est imposé : **la possibilité de vivre-ensemble avec les sorciers, ces individus porteurs de handicaps spirituels**, n'est pas un simple idéal moral, mais un défi pratique et thérapeutique. Cette conclusion générale se propose de répondre à cette question centrale, de réfléchir à la paix comme choix conscient, et de réaffirmer le rôle de la MTHS comme discipline capable de **soigner l'invisible sans détruire l'humain**, tout en lançant un appel pour une Afrique plus lucide, plus juste et plus miséricordieuse.

I. PEUT-ON VRAIMENT VIVRE-ENSEMBLE AVEC LES SORCIERS ?

1. Déconstruire les mythes et les peurs

La société traditionnelle africaine a longtemps entretenu des récits autour des sorciers : figures redoutables, omniprésentes, capables de nuire à tout moment. Ces récits ont fonctionné comme des **mécanismes de contrôle social**, mais ils ont également généré des **traumatismes spirituels et psychologiques**. Les

enfants et les adultes vulnérables ont été exposés à des peurs permanentes, souvent légitimées par la tradition ou la religion.

La MTHS, en revanche, propose une **lecture clinique et symbolique** de ces phénomènes : les sorciers ne sont pas des entités intrinsèquement maléfiques, mais des individus porteurs de **handicaps spirituels** qui nécessitent soin, accompagnement et protection, et non persécution. Vivre-ensemble devient possible lorsqu'on **remplace la diabolisation par la compréhension**, l'accusation par le discernement, et la peur par la vigilance constructive.

2. Cohabitation et limites saines

Vivre-ensemble ne signifie pas naïveté ni soumission. La MTHS distingue clairement la **cohabitation sécurisée** de la **complicité involontaire avec le mal**. Des **limites claires**, des protections spirituelles et des rituels non violents sont nécessaires pour préserver la sécurité de la famille et la stabilité psychologique des enfants et adultes vulnérables.

Le cas clinique nous enseigne que parfois, **la distance thérapeutique** est préférable à l'affrontement direct : elle permet d'éviter l'escalade de la violence symbolique ou physique, tout en laissant la possibilité d'un accompagnement progressif et sécurisant. Ainsi, la coexistence repose sur un **équilibre dynamique**, où chaque membre sait respecter l'espace et les limites de l'autre, tout en maintenant le lien familial et social.

II. La paix comme choix thérapeutique et spirituel

1. La paix comme stratégie de résilience

La paix n'est pas un état passif ; elle est **un choix conscient**, un acte de courage et de responsabilité. Elle suppose de résister à la tentation de la vengeance, de la stigmatisation et de la peur. Dans ce contexte, elle devient **thérapeutique** : elle protège les individus vulnérables, limite les traumatismes spirituels et favorise la guérison psychologique et sociale.

En famille, la paix se manifeste par des pratiques concrètes :

- la communication sécurisante ;
- l'éducation des enfants au discernement et à la vigilance constructive ;
- l'accompagnement progressif des membres porteurs de handicaps spirituels.

Au niveau communautaire, elle implique des normes éthiques, une supervision bienveillante et la création d'espaces de dialogue intergénérationnel. La paix devient ainsi **un projet collectif**, où chaque individu est à la fois acteur et bénéficiaire.

2. La paix comme engagement spirituel

Sur le plan spirituel, la paix ne se limite pas à l'absence de conflit : elle se construit dans l'**harmonie avec l'invisible**, dans le respect des croyances et des traditions, et dans la responsabilité individuelle face aux forces

symboliques. Choisir la paix, c'est **refuser la logique de chasse aux sorciers**, c'est exercer le discernement, et c'est intégrer la vigilance, le soin et la protection dans la vie quotidienne.

III. LA MTHS : SOIGNER L'INVISIBLE SANS DETRUIRE L'HUMAIN

1. La MTHS comme approche holistique

La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels se distingue par sa capacité à traiter ce qui est invisible – les perturbations spirituelles, les traumatismes symboliques, les dynamiques familiales perturbées – **sans recourir à la violence ou à la stigmatisation**. Elle combine :

- des protocoles cliniques de désenvoûtement encadré ;
- un accompagnement progressif et sécurisant ;
- la restauration des liens familiaux et communautaires ;
- la prévention des rechutes spirituelles et psychologiques.

En pratique, elle considère que **chaque être humain mérite protection et respect**, même lorsqu'il est porteur de handicaps spirituels, et que la guérison collective passe par l'éthique, la patience et le discernement.

2. Les outils thérapeutiques de la MTHS

La MTHS propose des outils précis pour intervenir de manière responsable :

- **Diagnostic différentiel spirituel** : identifier le type et le niveau de handicap spirituel sans diaboliser ;
- **Interventions encadrées** : désenvoûtement progressif, rituels sécurisants, accompagnement spirituel et psychologique ;
- **Surveillance bienveillante** : la famille et la communauté participent à la prévention et à la réhabilitation ;
- **Communication thérapeutique** : parole apaisante, médiation intergénérationnelle, réintégration progressive.

Ces outils permettent de **prévenir la répétition des traumatismes** et de créer un environnement où la coexistence est non seulement possible, mais constructrice.

IV. APPEL A UNE AFRIQUE PLUS LUCIDE, PLUS JUSTE ET PLUS MISERICORDIEUSE

1. Lucidité : voir sans diaboliser

Une Afrique lucide est une Afrique capable de **regarder la réalité des pratiques spirituelles et des handicaps invisibles sans recourir à la peur**. La lucidité implique une observation critique, une formation des leaders et des familles, et une compréhension des dynamiques sociales et psychologiques. Elle permet d'éviter les excès de stigmatisation et de sanction, tout en maintenant la sécurité collective.

2. Justice : protéger sans détruire

La justice, dans ce cadre, ne se limite pas à la sanction : elle consiste à **protéger les individus vulnérables**, à encadrer les

pratiques rituelles, et à assurer que les conflits spirituels ne deviennent pas des instruments d'oppression. Elle implique que chaque membre de la famille et de la communauté soit traité avec respect et dignité, même lorsqu'il est porteur de handicaps spirituels.

3. Miséricorde : restaurer et accompagner

La miséricorde est l'âme de la MTHS : elle se traduit par la patience, l'accompagnement progressif, le soin, et la réintégration sécurisée des individus dans la famille et la communauté. C'est elle qui permet de **transformer la peur en vigilance constructive**, la colère en dialogue, et la suspicion en discernement. La miséricorde devient ainsi un **outil de prévention et de guérison**, capable de briser le cycle des traumatismes intergénérationnels.

V. SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES

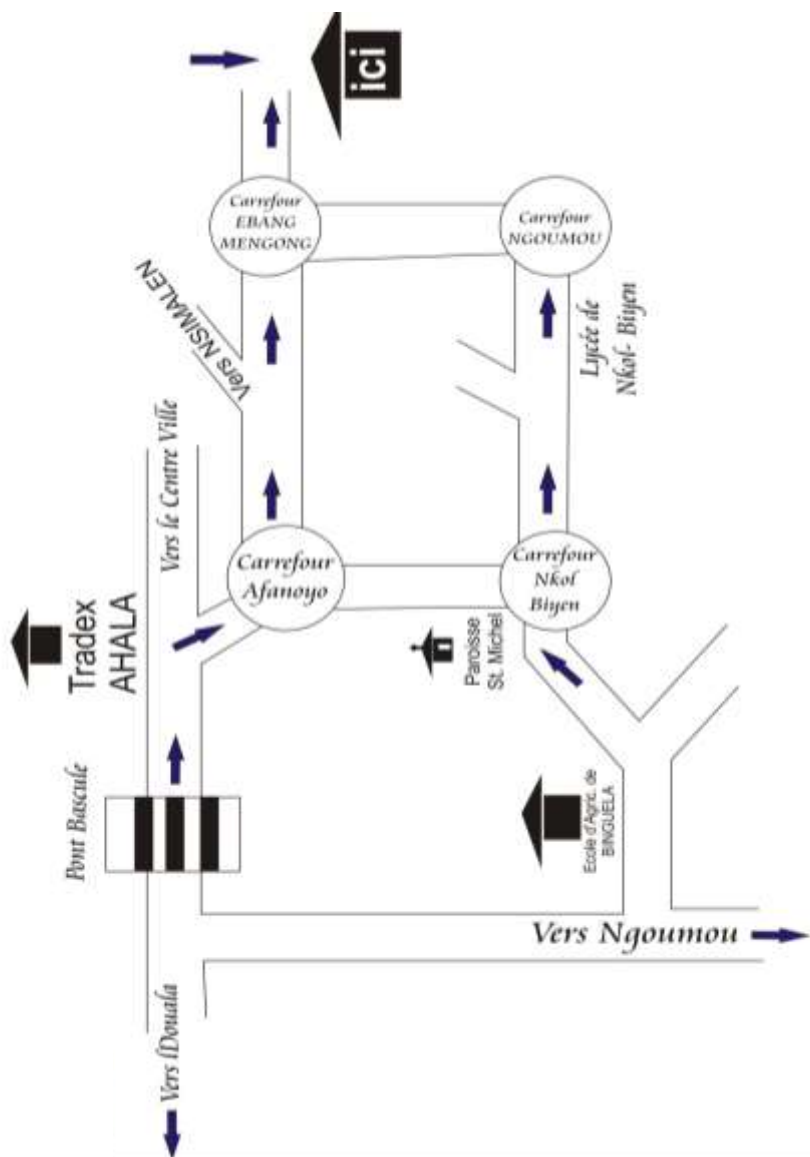
Ce livre a démontré que **vivre-ensemble avec les sorciers n'est pas seulement possible, mais souhaitable**, lorsque l'on applique les principes de la MTHS : discernement, limites saines, prévention, accompagnement et éthique. Les familles et les communautés peuvent devenir des lieux de guérison et de prévention, où la peur cède la place à la confiance, où la violence cède la place à la vigilance constructive, et où l'invisible devient un espace de responsabilité et de soin plutôt que de stigmatisation.

La MTHS offre une méthodologie claire : **soigner l'invisible sans détruire l'humain**, prévenir les traumatismes, restaurer les liens et renforcer la résilience collective. Elle montre que la coexistence spirituelle, la paix familiale et communautaire, et la prévention des conflits intergénérationnels sont des objectifs atteignables.

Un appel à l'Afrique et au monde

Enfin, cet ouvrage se conclut par un appel : **à une Afrique lucide, capable de comprendre l'invisible sans le diaboliser ; à une Afrique juste, qui protège sans détruire ; à une Afrique miséricordieuse, qui soigne et réintègre plutôt qu'elle ne condamne.** Dans ce projet, la famille devient le centre de la guérison, la communauté le cadre de la vigilance, et chaque individu un acteur responsable de la paix spirituelle.

C'est dans cette dynamique que l'avenir se dessine : un futur où le soin, la prévention et la responsabilité collective remplacent la peur et la stigmatisation, et où **la culture de paix spirituelle devient le socle d'une Afrique plus humaine, plus éthique et plus durable.**



PLAN de localisation de la clinique de **Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels** « **MARIE REINE DE LA MISERICORDE D'ABILI** » au CAMEROUN
 BP: 12561 YAOUNDE (CAMEROUN),
 Tél: (237) 677 31 44 12 / Tél: (237) 693 21 54 31

La sorcellerie divise, effraie et détruit silencieusement de nombreuses familles africaines. Accusations hâtives, délivrances violentes, exclusions injustes : au nom de la lutte contre le mal, la paix familiale est souvent sacrifiée. Comment vivre-ensemble avec les sorciers, afin de préserver la paix dans ta famille ose briser ce cercle destructeur en proposant une approche profondément humaine, thérapeutique et spirituelle.

À contre-courant des discours extrêmes, l'Association Mariale d'Abili invite à un changement radical de regard. Ici, la sorcellerie n'est ni niée ni banalisée, mais comprise comme l'expression d'un déséquilibre intérieur, d'un handicap spirituel et relationnel nécessitant discernement, accompagnement et soin. L'ouvrage démontre comment la violence spirituelle, souvent légitimée par la peur ou le zèle religieux, engendre plus de traumatismes que de guérisons.

S'appuyant sur l'expérience de terrain et la Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS), ce livre trace un chemin audacieux : préserver la paix sans justifier le mal, soigner l'invisible sans détruire les personnes, restaurer les liens familiaux sans céder au déni. Accessible, profond et dérangeant, cet ouvrage s'adresse aux familles, aux leaders spirituels et à toute personne en quête de sagesse face aux conflits spirituels. Un livre nécessaire pour transformer la peur en discernement et la violence en paix durable.



ISBN : 978-9956-00-000-0



En l'an 2000, Jean Paul Sylvain SIDA ABENA a reçu du Seigneur JESUS CHRIST la mission et les pleins pouvoirs de dévoiler au grand jour tous les secrets du Diable, le Malin, afin de sortir les hommes de la prison de l'ignorance qui les maintient dans la persécution du Diable, des démons et du phénomène de la sorcellerie.

Jean Paul Sylvain SIDA ABENA est le Fondateur du Centre de traitements spirituels "MARIE REINE DE LA MISERICORDE D'ABILI", dans l'arrondissement de BIKOK (CAMEROUN).

Il est le Précurseur de trois disciplines scientifiques :

- 1- L'Etude Systématique de l'Esprit Humain,
- 2- La SORCIORLOGIE : l'Etude des comportements de déviance, des déviations spirituelles et des évolutions spirituelles du phénomène de la sorcellerie,
- 3- La Médecine Traditionnelle des Handicapés Spirituels (MTHS) dont la Mission est de : « Guérir l'âme, restaurer le corps, libérer l'esprit ». Il s'agit d'une médecine incultivée qui associe Tradition, nature et spiritualité au service de la Santé Holistique. À ce jour, cette médecine est actuellement codifiée, documentée, enseignée et diffusée par l'Association Mariale d'ABILI (ASMAB).